



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI**

**BULAN NOVEMBER
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum/Latar belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Disisi lain, rumah sakit menjadi mata rantai transmisi penyakit. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai nega di dunia, termasuk Indonesia. Dalam forum *Asian Pasific Economic Comitte* (APEC) atau *Global Health Security Agenda* (GHSA) penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara.

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, perawatan pasien tidak hanya dilayani di rumah sakit saja tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bahkan di rumah (*home care*).

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/PER/II/2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Kesehatan Lingkungan RS ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
12. Keputusan Direktorat Jendal No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor

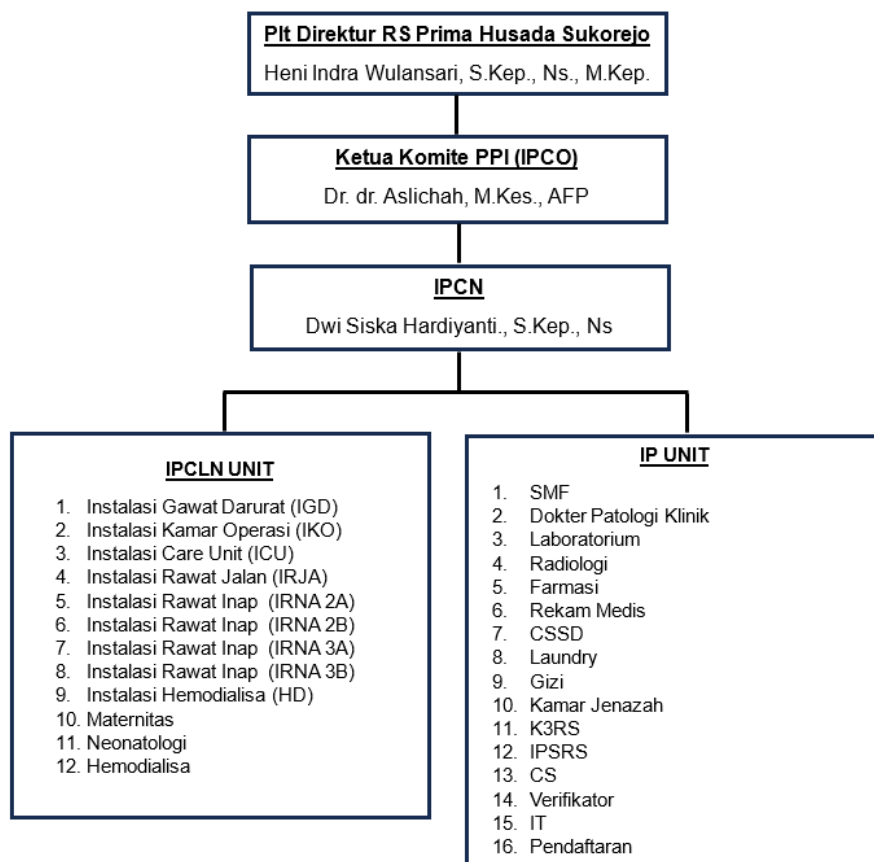


1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai panduan untuk pencapaian visi dan misi RS Prima Husada Sukorejo dalam mencapai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan professional melalui penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, sehingga setiap individu dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur.

- 1.1 Visi
Menjadikan rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan Masyarakat
- 1.2 Misi
 1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat.
 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
- 1.3 Motto
“Clean Hands, Save Lives”
- 1.4 7 Nilai Budi Utama
 1. Jujur
 2. Tanggung jawab
 3. Dipercaya
 4. Visioner
 5. Kerjasama
 6. Adil
 7. Peduli
- 1.5 SOTK

SOTK KOMITE PPI

BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
- 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Jumlah SDM												Kebutuhan	Ket.
		Bulan Ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IPCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Peremenkes No 27 tahun 2017 1 IPCN = 100 TT
IPCD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	
IPCN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1-2	

- 3.1.2 Orientasi
- Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi PPI RSPH Pasuruan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi orientasi
1.	Januari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Januari 2025		
2.	Februari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Februari 2025		
3.	Maret	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Maret 2025		
4.	April	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan April 2025		
5.	Mei	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Mei 2025		
6.	Juni	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Juni 2025		
7.	Juli	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Juli 2025		
8.	Agustus	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Agustus 2025		
9.	September	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan September 2025		
10.	Oktober	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Oktober 2025		
11.	November	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan November 2025		
Total				

Tabel 3.1.4.1 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Surveilans

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Tabel 3.1.4.6 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit APD

[illegible]

[illegible]



Tabel 3.1.4.8 Hasil Penilaian PIC PPI Unit Bulan November 2025

UNIT	SURVEILANS	LAPBUL	EDUKASI	AUDIT HH	AUDIT APD	AUDIT PROGRAM	NILAI
ICU	97	80	100	90	89	0	76
IGD	87	78	73	90	95	0	70
IKO	47	55	0	50	46	0	33
IRJA	54	47	23	50	44	0	36
IRNA 2A	97	80	91	100	95	0	77
IRNA 2B	94	80	95	96	95	0	77
IRNA 3A	95	80	100	95	96	0	78
IRNA 3B	94	79	86	91	93	0	74
MATER	95	80	100	98	98	0	79
NEONATOLOGI	97	80	100	98	98	0	79
GIZI & DAPUR	0	80	0	98	95	0	45
FARMASI	0	76	9	87	64	0	39
LAB	0	35	0	76	87	0	33
RM & PDF	0	37	73	0	0	0	18
RADIOLOGI	0	37	9	29	20	0	16
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0



Tabel 3.1.4.9 Analisa dan Tindak Lanjut Penilaian Kinerja PIC PPI Unit 2025

Analisa	Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi penilaian kinerja staf IPCLN dan PIC PPI bulan November tahun 2025 dengan penugasan sebagai berikut, - Pelaporan surveilans - Pelaporan dan penginputan laporan <i>by link</i> - Pemberian edukasi kelompok dan individu dengan sasaran pasien, pengunjung serta staf unit - Pelaporan audit HH - Pelaporan audit APD - Pelaporan audit program Dapat diketahui bahwa pelaporan belum berjalan secara maksimal, dan masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan secara <i>real time</i>. Adapaun unit dengan rerata skoring tertinggi dan menjadi PIC teladan pada bulan November tahun 2025 yakni Neonatologi dan Maternitas dengan skor 79
Rencana Tindak Lanjut	- Berikan penilaian kinerja setiap bulan pada saat melakukan rapat koordinasi komite PPI - Lakukan koordinasi dengan SDM dan berikan reward kepada unit teladan setiap bulannya - Lakukan koordinasi dengan Kabid terkait hasil temuan-temuan setiap bulannya - Lakukan perbaikan dengan IPCN setiap kali melakukan agenda rapat dalam pembahasan temuan-temuan serta kendala pada masing-masing unit umum, pelayanan dan penunjang - Berikan motivasi kepada semua PIC PPI unit yang baik yang sudah dan belum maksimal dalam melakukan penugasan serta evaluasi secara bersama dengan IPCN - Lakukan koordinasi dengan Kabid serta SDM terkait kepatuhan unit dan staff dalam proses menjadi seorang PIC PPI di unit serta dalam melakukan monitoring PPI di masing-masing unit



3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan

Tabel 3.2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan	Bulan	Hasil	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelatihan	Januari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Januari 2025		
2	Pelatihan	Februari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Februari 2025		
3	Pelatihan	Maret (22/03/2025)	1. IDO (Infeksi daerah operasi) bisa di sebabkan oleh faktor endogen (usia, penyakit penyerta, jenis kelamin, pola hidup) dan eksogen (tipe dan lama operasi, keahlian tim bedah, pemilahan operasi, pemasangan impaln, sterilisasi instrumen bedah, kualitas ruang op, kualitas fasilitas/peralatan yang ada di ruang operasi) 2. 4 klasifikasi luka IDO 1) Luka bersih 1-2% 2) Bersih terkontaminasi 6-9% 3) Luka terkontaminasi 13-20% 4) Luka kotor 40% 3. Pemberian profilaksis di lakukan 1 jam sebelum insisi dan sesegera mungkin sebelum dilakukan pembedahan 4. Pemberian profilaksis harus berbeda dengan terapi AB yang digunakan pasien selama proses rawat inap 5. Dikatakan IDO ketika 1) post op hari ke 30-90 yang disertai dengan demam, kemerahan, bengkak, keluar pus	1. Belum adanya SPO pembersihan ruang IKO yang ter-update 2. Tidak patuh dan rutinnya jadwal bongkaran di ruang IKO 3. Tidak patuhnya staff IKO dalam melakukan tatalaksana ruang operasi sesuai dengan prosedur 4. Penerapan bundle IDO di RS belum berjalan sesuai dengan standart 5. Jadwal pemberian profilaksis (antibiotik) di setiap unit masih belum berjalan maksimal 60 menit sebelum jam insisi 6. Masih ditemukan alat di ruang IKO tidak terpusat di CSSD dalam proses pembersihan	1. Pembuatan SPO pembersihan ruang IKO 2. Pembuatan jadwal bongkaran IKO 3. Sosialisasi dan re-edukasi kepatuhan petugas dalam melaksanakan tatalaksana ruang operasi 4. Penerapan bundle IDO oleh unit IKO dan all unit rawat inap serta rawat jalan 5. Edukasi pemberian profilaksis (antibiotik) harus 60 menit sebelum insisi 6. CSSD melakukan pendaataan dan edukasi ulang terkait instrumen yang ada di IKO wajib dilakukan pembersihan dan sterilisasi di CSSD



			2) golden period terjadi pada hari ke 0-30 hari 6. Dampak IDO 1) memperpanjang masa rawat, sering re-admisi, kebutuhan ICU 2) mortalitas meningkat 3) disabilitas permanen 4) prosedur bedah tambahan 5) kontribusi pada peningkatan resistensi antibiotik 7. Teknik penerapan IDO 1) Pre operatif : mandi dengan clorhexidin sehari sebelum op dan hari H ketika proses pembedahan, pencukuran menggunakan cleaper (dilakukan di RS supaya terkontrol oleh petugas tekniknya), pemberian antibiotik kurang dari 120 menit 2) Intra operatif : pemberian O2, pemantauan suhu tubuh, pemantauan gula darah 8. Bongkaran/pembersihan IKO 1) pembersihan harian (dilakukan selama prosedur op telah selesai semua) 2) bongkaran 1 minggu sekali (dilakukan secara rutin dan terjadwal) 3) bongkaran 1 bulan sekali 4) pembersihan pasca renovasi 9. Pembersihan lingkungan		
--	--	--	--	--	--



			1) terdapat SPO tersendiri dalam pembersihan ruang khusus (iko) 2) melakukan pemeriksaan lingkungan secara rutin (6 bulan sekali) 10. kualitas ruang operasi 1) pintu otomatis 2) tempat cuci tangan menggunakan sensor 11. alur instalasi ruang bedah 1) zona luar : koridor masuk, area transfer, nurse station, area dokumentasi, preoperasi, area ganti baju 2) zona bersih : koridor bersih, ruang simpan alat steril, ruang anastesi dan RR, area istirahat 3) zona retriksi : scrub sinks, ruang operasi 12. persiapan alat/instrumen 1) alat "non kritis" 2) alat "semi kritis" 3) alat "kritis" 13. prinsip rawat luka pasien post op 1) assesmen komprehensif luka dan pasien 2) pengendalian infeksi 3) pemilihan dressing yang tepat 4) manajemen nyeri 5) pendidikan pasien dan keluarga 14. tata kelola kamar operasi		
--	--	--	--	--	--



			1) penjadwalan operasi : mengatur (mengatur kamar operasi, operator dna tim operasi, durasi op) 2) persiapan pasien 3) koordinasi tim medis 4) pengurangan waktu tunggu 5) alur pasien yang efisien 15. manajemen linen 1) penanganan linen di kamar op harus sesuai 2) pemisahan linen kotor terkontaminasi darah atau cairan tubuh dengan linen kotor tidak terkontaminasi 3) tidak menempatkan linen di lantai 4) semua linen infeksius dimasukkan ke dalam kantong dengan kode infeksius 5) linen yang terkontaminasi cairan tubuh dibersihkan sebelum proses selanjutnya 16. manajemen limbah 1) pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya 2) tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya 17. sterilisasi dan perawatan peralatan medis 1) sterilisasi alat bedah 2) desinfeksi permukaan 3) penyimpanan yang tepat 4) pemeliharaan yang rutin		
--	--	--	---	--	--



			18. semua peralatan/instrumen bedah wajib di lakukan sterilisasi di CSSD 19. ruang/gedung kamar operasi : boleh sampai dengan lt. 4 dengan memperhatikan struktur dan arah cahaya dari banguna		
4	Pelatihan	April 2025	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan April 2025		
5	Pelatihan	Mei 2025	Total Undangan: 466 peserta Total Kehadiran: 322 peserta Total Tidak Hadir: 144 peserta Persentase Kehadiran: 69,10% Persentase Ketidakhadiran: 30,90% Nilai Rata-Rata Peserta: Pre-Test : 88 / 100 Post-Test : 95 / 100 Rata-rata tanya jawab saat praktik : 74,06 / 80 Hasil Pelatihan PPI All Staff 1. Cuci Tangan a. Staff tidak melakukan pelepasan aksesoris, namun Ketika sudah dilakukan edukasi dan sosialisasi staff paham b. Langkah cuci tangan terbolak balik antara Langkah ke 3 dan ke 4 c. Langkah cuci tangan “mengunci” menjadi kendala dari staff pelatihan d. Langkah cuci tangan ke dua “punggung tangan” banyak staff yang tidak menempel kan	1. Kehadiran Peserta: Persentase kehadiran sebesar 69,10% menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, namun masih ada sekitar 30,90% peserta yang tidak hadir. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut terkait alasan ketidakhadiran (jadwal, sosialisasi, dukungan pimpinan, dsb). 2. Peningkatan Nilai - Terdapat peningkatan nilai dari 88 (pre-test) menjadi 95 (post-test), yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap materi PPI meningkat setelah pelatihan. - Rata-rata post-test mendekati sempurna, mengindikasikan bahwa materi disampaikan dengan efektif dan dapat diterima dengan baik oleh peserta.	1. Evaluasi Ketidakhadiran: - Lakukan survei singkat atau konfirmasi ke unit terkait untuk mengetahui penyebab utama ketidakhadiran 146 peserta. - Koordinasikan dengan pimpinan unit untuk mendukung keikutsertaan dalam pelatihan selanjutnya. 2. Pelatihan Ulang: - Jadwalkan sesi pelatihan susulan atau pelatihan ulang bagi peserta yang tidak hadir untuk memastikan seluruh SDM memahami PPI dasar. 3. Monitoring dan Implementasi - Lakukan audit kepatuhan terhadap PPI pasca pelatihan untuk menilai penerapan di unit kerja masing-masing



			telapak tangan ke punggung tangan e. Masih ada beberapa staff yang tidak hafal 5 momen cuci tangan f. Masih ada beberapa staff yang tidak hafal terkait waktu cuci tangan g. Masih belum pahamnya staff terkait tujuan dan manfaat cuci tangan 2. Spillkit a. Staff belum paham penggunaan spillkit b. Staff tidak paham isi dan kegunaan spillkit c. Staf masih bingung terkait Langkah-langkah penggunaan spill kit dan masih terbolak balik Langkah, a) Penggunaan APD (urutan penggunaan dan pelepasan APD) b) Penyiapan kresek c) Pemberian pasir/serbuk kayu dengan jarak 10-20 cm d) Kapan pemberian klorin pada saat ada tumpahan DUH pasien e) Penggunaan klorin tidak di pakai pada saat terjadi tumpahan B3	- Rata-rata tanya jawab langsung ketika melakukan praktikum sebesar 74,06 yang menunjukkan peserta 3. Kurang patuhnya staff unit dalam menerapkan 6 langkah cuci tangan dan	- Berikan feedback berkala ke unit terkait praktik PPI (misalnya: kebersihan tangan, penggunaan APD, etika batuk, dll) 4. Peningkatan Berkelanjutan: - Sertakan materi PPI dasar dalam orientasi karyawan baru. - Rancang materi PPI lanjutan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman dan kompetensi staf Rencana Tindak Lanjut terkait Materi praktek dalam PPI, 1. Cuci Tangan a. Melakukan pelatihan ulang berbasis demonstrasi langsung dan praktik. b. Menyediakan poster visual 6 langkah cuci tangan dan 5 momen WHO di setiap unit. c. Evaluasi dan simulasi periodik. d. Kampanye mini tentang manfaat cuci tangan
--	--	--	---	---	--



			3. Penggunaan APD a. Staff belum paham dan masih terbolak balik dalam urutan penggunaan APD b. Staff belum paham dan masih terbolak balik dalam urutan pelepasan APD c. Kebutuhan APD di unit sudah terpenuhi, hanya unit IRNA 2A (R. Isolasi yang belum memenuhi kebutuhan APD masker N95 yang diperuntukkan untuk masuk keruang isolasi) 4. Pemilahan sampah a. Staff bingung dalam melakukan pembuangan cairan DUH pasien dan pembuangan botol yang terkena DUH pasien infus kemana b. Staff bingung dalam melakukan pengikatan sampah infeksius/non infeksius/ botol infus 5. Penanganan Linen a. Staff masih bingung Ketika ditemukan DUH pasien di linen (harus di buang dulu DUH pasien) lalu di masukkan kedalam kresek infeksius 6. Proses Dekontaminasi alat a. Staff masih bingung untuk proses awal perendaman / dekontaminasi dari unit (alat		melalui media internal (TV, flyer, poster). e. Penugasan role model (champion hygiene) di tiap unit. 2. Spillkit a. Melakukan pelatihan ulang menggunakan alat spillkit secara langsung. b. Membuat SOP visual/spillkit flowchart yang ditempatkan di area risiko tinggi. c. Simulasi rutin tumpahan DUH dan B3. d. Pemberian kartu ringkasan urutan spillkit untuk staf. 3. Penggunaan APD a. Pelatihan ulang dengan simulasi step-by-step penggunaan dan pelepasan APD. b. Penambahan kebutuhan APD ke IRNA 2A. c. Menempelkan panduan poster urutan APD di setiap ruang tindakan.
--	--	--	--	--	---



			direndam terlebih dahulu menggunakan cairan deterjen kemudian di turunkan ke CSSD) b. Beberapa alat setelah di pakai tidak di turunkan dikarenakan lupa, dan hanya diletakkan di dalam kresek kuning, bukan di box instrument kotor		d. Pembuatan video internal panduan penggunaan APD. 4. Pemilahan Sampah a. Penyusunan ulang SOP pemilahan limbah dengan contoh visual. b. Sosialisasi dan simulasi secara langsung. c. Penempatan label warna yang jelas pada setiap kantong dan tempat sampah. 5. Penanganan Linen a. Sosialisasi prosedur penanganan linen terkontaminasi DUH secara rinci. b. Pelatihan simulasi dan role play. c. Penempatan instruksi singkat di area laundry dan tempat pengumpulan linen. 6. Dekontaminasi Alat a. Edukasi ulang urutan dekontaminasi alat: dari perendaman hingga
--	--	--	---	--	--



					pengiriman yang dilakukan oleh statff CSSF b. Audit harian terhadap kepatuhan pengiriman alat kotor ke CSSD.
6	Pelatihan	Agustus 2025	1. Pemasangan CVC tidak boleh dilakukan di vena femoral. 2. Penggunaan APD harus lengkap sesuai urutan dari bawah ke atas (sepatu, gown, masker, nurse cap, google, sarung tangan steril, drapping). 3. Bundle CLABSI wajib diterapkan di unit khusus, mulai sebelum hingga setelah penggunaan CVC. 4. Pasien yang diduga CLABSI harus dilakukan kultur darah (perbandingan kanan dan kiri) sesuai regulasi dan SPO. 5. Pasien dengan CVC dari luar harus dipertahankan maksimal 1x24 jam kemudian diganti sesuai prosedur. 6. Pasien hemodialisa dengan CVC wajib dilakukan kultur darah bila ada indikasi infeksi.	1. Risiko tinggi CLABSI masih dapat terjadi bila pemasangan dilakukan di vena femoral karena lokasi ini rawan kolonisasi bakteri. 2. Kepatuhan penggunaan APD sering menjadi kendala di lapangan sehingga perlu pengawasan ketat. 3. Bundle CLABSI belum konsisten diterapkan di semua unit, sehingga perlu standarisasi. 4. Kultur darah penting untuk diagnosis pasti CLABSI, namun masih ada keterlambatan atau ketidaksesuaian prosedur. 5. CVC dari luar sering dipertahankan melebihi 24 jam karena kurangnya pengawasan, meningkatkan risiko infeksi. 6. Pasien HD dengan CVC berisiko tinggi infeksi, sehingga kultur darah wajib untuk deteksi dini.	1. CVC dipasang di vena femoral RTL : Revisi SPO dan sosialisasi pemasangan CVC (hindari vena femoral) Penanggung jawab : Komite medik dan komite PPI Waktu : 2 minggu 2. Kepatuhan penggunaan APD RTL : Monitoring dan evaluasi kepatuhan APD< breafing rutin sebelum tindakan Penanggung jawab : IPCN, kepala ruang Waktu : Rutin 3. Bundle CLABSI belum konsisten RTL : implementasi bundle CLABSI di seluruh unit khusus Penanggungjawanan : Tim PPI dan Kepala Ruang Icu/HD Waktu : 1 bulan 4. Kultur darah tidak sesuai dengan SPO RTL : penyusunan dan sosialisasi SPO kultur darah, pelatihan teknis pengambilan



					Penanggungjawaban : lab mikrobiologi dan komite medik Waktu : 1 bulan 5. CVC dari luar >24 jam RTL : pengawasan dan pencatatan waktu pemasangan CVC dari luar Penanggungjawab : Perawat ruangan, DPJP Waktu : Rutin 6. Pasien HD dengan CVC berisiko infeksi RTL : wajib kultur darah pasien HD dengan CVC bila indikasi infeksi Penanggungjawab : Dokter Sp.PD dan perawat HD Waktu : Rutin

3.3 Kinerja Produktifitas Komite PPI

3.3.1 Kewaspadaan Isolasi

a. Kewaspadaan Standart

Tabel 3.3.1.1 Kewaspadaan Standart

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	PENYUNTIKAN YANG AMAN	80,00%	89,30%	86,50%	82,22%	81,64%	95,37%	89,54%	80,16%	80,56%	86,11%	86,11%	88,88%		86,04%	86,01%	88,85%	82,28%	87,50%
2	PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI VAKSIN	80,00%	100,00%	94,44%	95,39%	92,88%	100,00%	100,00%	93,45%	100,00%	98,68%	98,82%	97,89%		97,41%	96,61%	97,63%	97,38%	98,36%
3	PENGELOLAAN STERILISASI DAN BMHP	80,00%	97,24%	92,72%	90,27%	93,33%	95,80%	96,28%	91,60%	95,59%	97,65%	90,44%	94,12%		94,09%	93,41%	95,14%	94,95%	92,28%
4	PENGELOLAAN LINEN/LAUNDRY	80,00%	96,43%	88,31%	89,01%	87,07%	90,48%	94,44%	89,88%	87,50%	91,83%	90,48%	93,88%		90,85%	91,25%	90,66%	89,74%	92,18%
5	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS RS	80,00%	100,00%	94,05%	94,41%	96,88%	96,58%	98,77%	96,30%	94,91%	97,61%	97,57%	97,76%		96,80%	96,15%	97,41%	96,27%	97,67%
6	PENANGANAN SPESIMEN DARAH DAN CAIRAN TUBUH LAIN	80,00%	90,48%	100%	92,50%	96,88%	98,75%	98,75%	100,00%	100,00%	92,66%	97,50%	98,61%		96,92%	94,33%	98,13%	97,55%	98,06%
7	PENANGANAN TUMPAHAN DARAH DAN CAIRAN TUBUH	80,00%	91,09%	85,96%	84,43%	94,05%	89,90%	95,22%	92,21%	95,00%	91,07%	94,44%	98,61%		92,00%	87,16%	93,06%	92,76%	96,53%
8	PENANGANAN DAN PENGIRIMAN SAMPAH DI RUANGAN	80,00%	93,33%	95,36%	84,63%	90%	93,75%	91,41%	90,52%	93,33%	92,96%	94,32%	91,45%		91,91%	91,11%	91,72%	92,27%	92,89%
9	PEMBUANGAN BENDA TAJAM	80,00%	72,77%	72,08%	87,73%	92,71	94,64%	92,36%	90,03%	87,50%	87,99%	94,88%	93,75%		87,86%	77,53%	93,24%	88,51%	94,32%
10	PELAYANAN MAKANAN	80,00%	75,00%	90,83%	85,00%	91,64%	94,17%	94,05%	88,33%	89,17%	87,50%	92,59%	93,65%		89,27%	83,61%	93,29%	88,33%	93,12%
11	LINGKUNGAN RUMAH SAKIT	80,00%	33,70%	63,31%	70,94%	95,17%	85,71%	86,24%	86,72%	89,10%	90,75%	91,19%	98,37%		80,93%	56,65%	88,05%	88,86%	94,78%
12	KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN APD DI UNIT	80,00%	96,45%	91,42%	94,21%	95,17%	99,38%	92,70%	100,00%	100,00%	91,29%	99,02%	93,00%		95,69%	94,03%	95,75%	97,10%	96,01%
13	KAMAR JENAZAH	80,00%	87,50%	91,43%	95,24%	100%	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%		95,99%	91,39%	100,00%	93,89%	100,00%
14	FASILITAS KEBERSIHAN TANGAN	80,00%	96,59%	95,83%	93,43%	91,89%	94,97%	93,33%	86,66%	93,71%	90,17%	88,05%	94,03%		92,61%	95,28%	93,40%	90,18%	91,04%
15	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULAN	80,00%	95,00%	90%	87,78%	96,67%	91,16%	83,33%	86,67%	83,33%	83,33%	90,00%	83,33%		88,24%	90,93%	90,39%	84,44%	86,67%
16	ETIKA BATUK	80,00%	98,61%	99,16%	78,85%	90,28%	86,67%	89,29%	81,48%	91,67%	90,91%	85,19%	82,58%		88,61%	92,21%	88,75%	88,02%	83,89%

17	KELENGKAPAN PENGISIAN DATA PPI	80,00%	47,08%	58,53%	75,43%	67,58%	74,49%	73,37%	85,41%	90,00%	67,86%	80,59%	81,54%		72,90%	60,35%	71,81%	81,09%	81,07%
----	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

b. Kewaspadaan Isolasi

Tabel 3.3.1.2 Kewaspadaan Isolasi

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	PENEMPATAN PASIEN INFEKSI AIRBONE DALAM WAKTU SINGKAT	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2	PENEMPATAN PASIEN IMMUNOCOMPROMISED	80,00%	62,50%	58,33%	95,00%	85%	58,33%	83,33%	72,73%	100,00%	91,66%	96,68%	96,88%		81,86%	71,94%	75,55%	88,13%	96,78%
3	PENEMPATAN DAN TRANSFER INFEKSI PASIEN AIRBONE	80,00%	63,49%	73,15%	78,42%	68,25%	68,52%	87,50%	77,45%	80,95%	69,23%	76,67%	86,45%		75,46%	71,69%	74,76%	75,88%	81,56%

3.3.2 Audit Bundle HAI's PPI

Tabel 3.3.2.1 Audit Bundle HAI's PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CAUTI		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,48%	0%	0%	0	0%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	CLABSI		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0%	0	0%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	VAP		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0%	0%	0%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	PLEBITIS & PLABSI		1,39%	1,14%	2,41%	2,08%	3,49%	3,46%	2,27%	2,88%	3%	3,73%	2%		2,61%	1,65%	3,01%	2,93%	2,97%
5	IDO		0%	0,89%	1,19%	0%	0%	0%	0,00%	0,55%	0%	0%	0%		0,26%	0,69%	0,09%	0,18%	0,00%
6	DEKUBITUS		0%	0%	2	0	0	0	1	0	0	0	0		0,2727273	0,66666667	0	0,3333333	0

Tabel 3.3.2.2 Audit Bundle HAI'S PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KET	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CAUTI (ISK)	HARI PEMAKAIAN	62	142	174	195	52	82	209	205	218	290	162		163	126	110	211	226
2	CLABSI (CVC)		11	10	13	4	4	7	35	12	20	3	2		11	11	5	22	2,5
3	VAP		41	13	34	14	30	28	40	25	39	18	35		29	29	24	35	26,5
4	IDO	JUMLAH PASIEN OP DALAM PERIODE TERTENTU (BULAN)																	
	SC		81	63	92	92	82	77	96	86	90	103	81		86	79	84	91	92
	ORIF		25	40	42	42	31	33	36	30	33	26	19		32	36	35	33	22,5
	APENDICTOMI		12	9	3	8	10	15	18	23	20	18	12		13	8	11	20	15
	HERNIOTOMI		25	22	11	16	28	22	21	17	18	26	20		21	19	22	19	23
	KATARAK		31	33	29	30	30	30	30	30	31	30	30		30	31	30	30	30
	CABG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	TU MAMAE		20	20	15	22	25	30	17	11	16	20	17		19	18	26	15	18,5
	LAPAROTOMI		26	37	22	13	19	30	32	31	25	23	21		25	28	21	29	22



3.3.3 Mutu PPI

Tabel 3.3.3.1 Mutu PPI 2025

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	62%	82,75%	81,80%	82,39%	96,86%	90,00%	90,00%	90%	82,80%	83,80%	86,40%		83,52%	75,38%	86,52%	87,60%	85,10%
2	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI's (Health care Associated Infection) di RS	75%	3,55%	1,07%	3,87%	6,33%	75,85%	69,66%	75,19%	76%	76,00%	80,77%	80,83%		49,92%	2,83%	50,61%	75,73%	80,80%
3	Kepatuhan kebersihan tangan	>85%	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%	76,39%	75,98%	74,81%	79,38%	89,47%		80,09%	76,98%	84,68%	75,73%	84,43%
4	Kepatuhan APD	100%	89,64%	89,87%	84,84%	97,92%	98,07%	93,80%	92,01%	84%	84,15%	91,48%	97,28%		91,17%	88,12%	96,60%	86,67%	94,38%
5	Angka infeksi daerah operasi	<1.5%	0%	0,89%	1,19%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%		0,24%	0,69%	0,00%	0,18%	0,00%
6	Kepatuhan penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	100%	52,46%	87,50%	97,14%	95%	100,00%	88,00%	90,00%	100%	86,96%	92,86%	100,00%		89,99%	79,03%	94,33%	92,32%	96,43%
7	Kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam	0 kejadian	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%		0,090909091	0	0,333333333	0	0
8	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	100%	55,24%	63,69%	60%	79,50%	72,75%	86,09%	90,00%	88,85%	90,00%	85,60%	88,33%		78,19%	59,64%	79,45%	89,62%	86,97%
9	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	100%	87,10%	83%	90,91%	97,31%	84,42%	90,91%	94,11%	94,11%	90,71%	96,15%	98,30%		91,61%	85,05%	90,88%	92,98%	97,23%
10	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	100%	47,13%	58,53%	59,26	56,67%	75,85%	78,54%	66,67%	69,58%	78,63%	77,78%	79,33%		68,00%	54,97%	70,35%	71,63%	78,56%
11	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh	100%	1,24%	1,37%	9,52%	11,90%	7,14%	16,67%	21,43%	100%	100,00%	66,67%	66,67%		36,60%	4,04%	11,90%	73,81%	66,67%
12	Edukasi kelompok terkait PPI	100%	27,28%	47,22%	55,88%	44,44%	44,12%	50,00%	47,06%	47,06%	88,89%	72,22%	81,25%		86,50%	80,83%	92,59%	92,59%	76,74%

BAB IV

PEMBAHASAN KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI

- 4.1

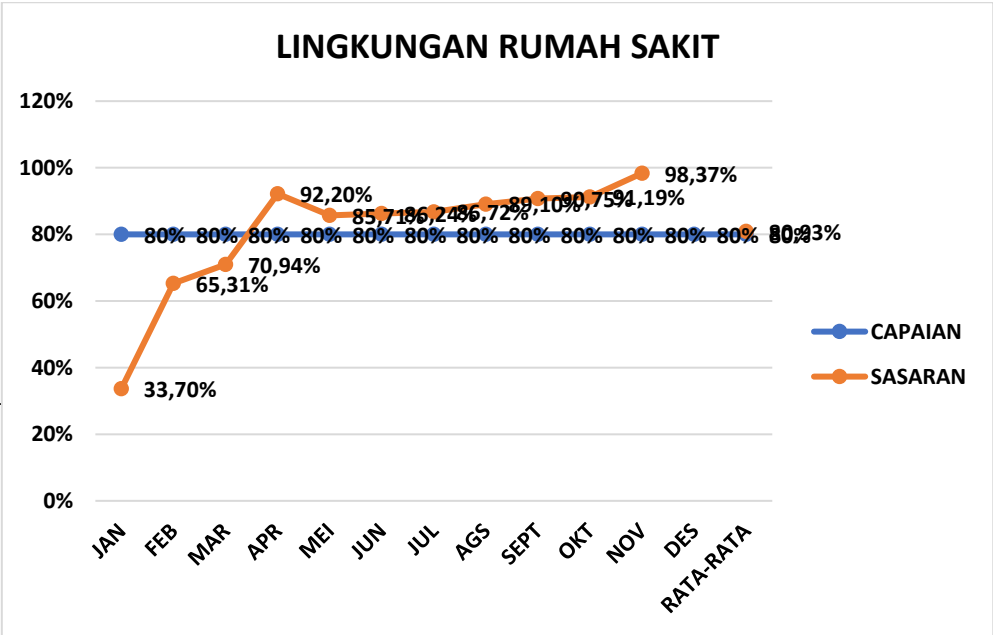
Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 4.1.1

Monitoring Kewaspadaan Isolasi
- a.

Kewaspadaan Standart
- a)

Lingkungan Rumah Sakit
- Gambar 4.1.1.1

Lingkungan Rumah Sakit



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.1 diketahui bahwa rerata lingkungan rumah sakit di bulan November 2025 sebesar 98,37% dengan rerata sebesar 80,93% dan sudah mencapai standart 80%.

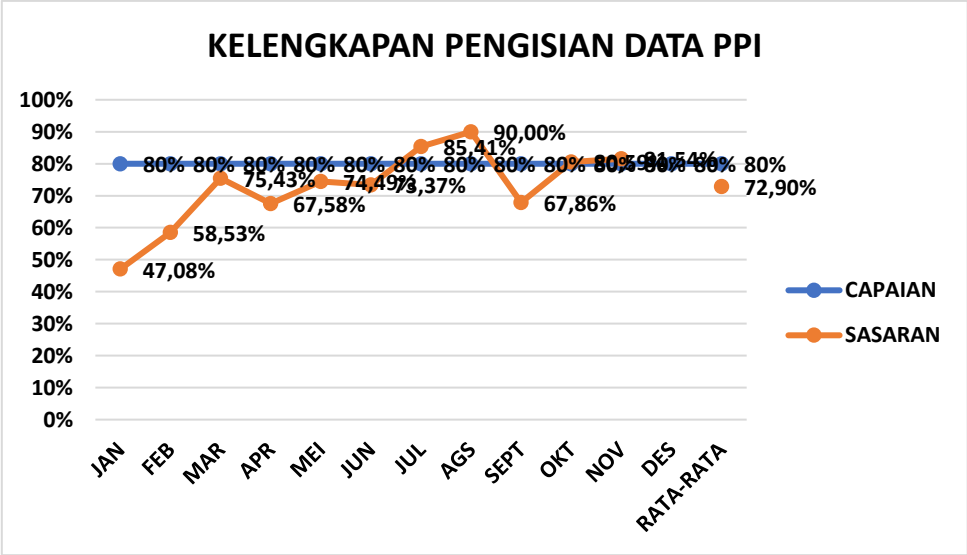
Tabel 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit

PROBLEM	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 98,37% dan sudah mencapai target 80%.
STEP	Monitoring berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan di area rumah sakit.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit hingga minimal 80% sesuai target pada semua bulan berjalan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya kepatuhan staff dalam menjaga kebersihan area kerja b. Pengawasan atau audit tidak berjalan setiap hari c. Tidak tersosialisasi dan tidak diterapkannya SOP terkait kebersihan lingkungan RS d. Kurangnya motivasi atau reward bagi petugas kebersihan yang berdinass

	4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan (baik secara mingguan dan memberikan umpan balik) b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Menyediakan cheklist kebersihan harian
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	1. Nilai kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 98,37% dengan rerata sebesar 80,93% dan sudah mencapai sasaran 80%. 2. Monitoring capaian kepatuhan setiap minggu 3. Lakukan perbandingan hasil kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan dengan bulan sebelumnya 4. Evaluasi area dengan peningkatan dan penurunan 5. Survei kepuasan staff dan petugas terhadap sistem baru
ACTION	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart 2. Beri feedback pada hasil temuan 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit dengan SOP dan audit sebagai standar rutin 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan SOP dan audit sebagai standar rutin

b) Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

Gambar 4.1.1.2 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata kelengkapan penginputan data surveilans di bulan November 2025 sebesar 81,54% dan belum mencapai standart 80%.



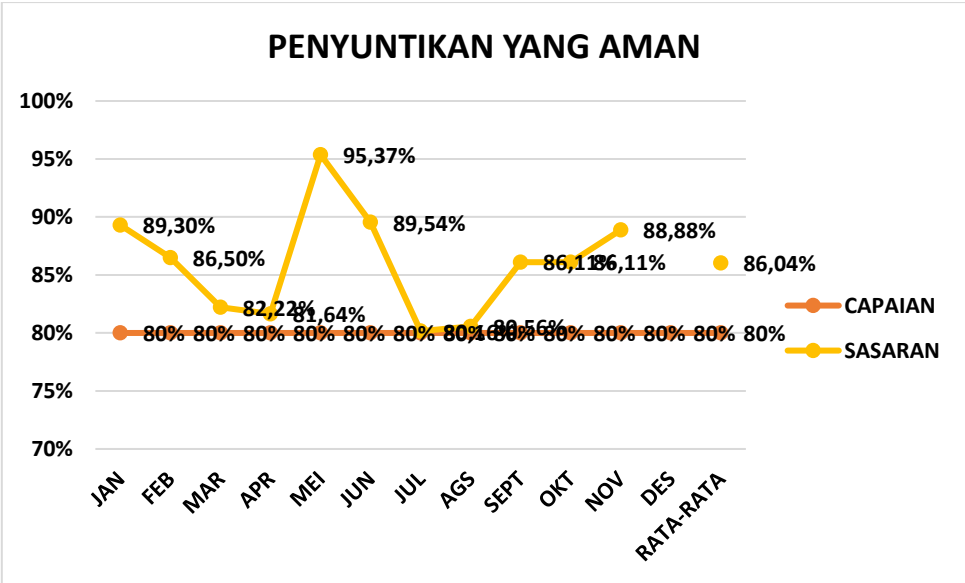
Tabel 4.1.1.2 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

PROBLEM	Persentase kelengkapan penginputan data surveilans bulan November tahun 2025 sebesar 81,54% dengan rerata sebesar 72,90% dan belum memenuhi target 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring 11 kewaspadaan transmisi serta kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kelengkapan pengisian data pencegahan dan pegendaian infeksi hingga mencapai target minimal 80% setiap bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara <i>real time</i> sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya pemahaman staff tetang pentingnya pencatatan data PPI b. Format pencatatan yang banyak yang harus di isi oleh PJ unit c. Tidak adanya system monitoring pengisian data secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring 11 kewaspadaan standart serta kewaspadaan isolasi c. Memberikan pelatihan kepada seluruh staff terkait pengisian data d. Monitoring mingguan oleh tim PPI terhadap pengisian data
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans belum mencapai target 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di bulan November 2025 sebesar 81,54% dengan rerata 72,90% dan belum memenuhi standart 80% 2. Lakukan survei terhadap staff untuk mengetahui hambatan dalam pengisian 3. Bandingkan tingkat kelengkapan data bulan berjalan dengan bulan sebelumnya
ACTION	1. Lakukan evaluasi pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi dengan melibatkan Karu dan Kabid terkait. 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faham

	4. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 5. Perbaiki format atau system pengisian berdasarkan masukan staff 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan
--	--

c) Penyuntikan Yang Aman

Gambar 4.1.1.3 Penyuntikan Yang Aman



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.3 diketahui bahwa rerata penyuntikan yang aman di bulan November 2025 sebesar 88,88% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

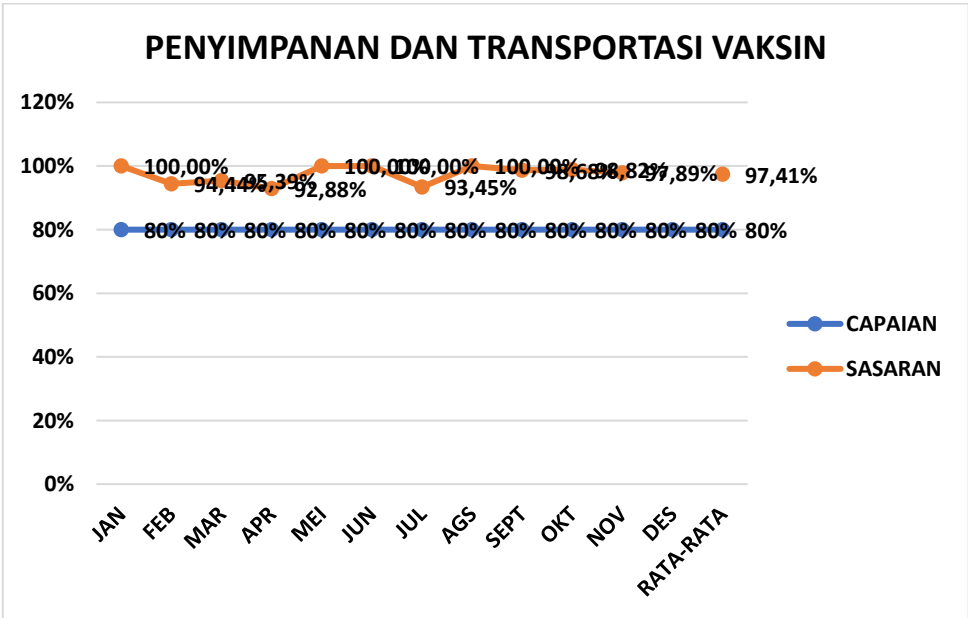
Tabel 4.1.1.3 Penyuntikan Yang Aman

PROBLEM	Kepatuhan terhadap Penyuntikan yang Aman (Sasaran) menunjukkan fluktuasi, sempat turun hingga 81,64% (Mei) dan rata-rata hanya 86,04%. Kepatuhan belum stabil di atas target kinerja terbaik.
STEP	Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang sering terlewatkan dalam prosedur penyuntikan yang aman: 1. Kebersihan Tangan sebelum dan sesudah injeksi, 2. Sterilitas Jarum/Spuit (tidak menggunakan ulang pada pasien berbeda atau mencemari bagian steril), dan 3. Pembuangan Limbah Tajam Segera.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Penyuntikan yang Aman agar mencapai minimal 90% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Tim PPI/Pengawas melakukan <i>coaching</i> singkat (5 menit) kepada perawat/staf yang bertanggung jawab di unit yang kepatuhannya rendah. b. Menerapkan <i>checklist</i> audit harian untuk memverifikasi 3P pada unit uji coba. c. Menyediakan <i>hand sanitizer</i> yang mudah dijangkau di setiap troli injeksi.



	3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan 3P (kebersihan tangan, sterilitas, pembuangan). b. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Penyuntikan yang Aman bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan <i>coaching</i> 3P di unit yang menjadi sasaran perbaikan. 2. Tim Pengawas melakukan audit observasi langsung (minimal 10 kali per minggu) menggunakan <i>checklist</i> 3P. 3. Memastikan semua troli/tempat injeksi dilengkapi dengan <i>hand sanitizer</i>.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap 3P. 2. Pertanyaan: Elemen 3P mana yang memiliki kepatuhan paling rendah? (Contoh: Pembuangan limbah tajam segera hanya 75%). 3. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan Penyuntikan yang Aman pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 86,04%). 4. Identifikasi Akar Masalah: Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah <i>safety box</i> untuk pembuangan terlalu jauh dari lokasi injeksi? * Apakah staf merasa terburu-buru dan melewatkan <i>hand hygiene</i>?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 90%, standardisasikan <i>checklist</i> audit 3P dan perluas penerapannya ke unit lain. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem pendukung berdasarkan elemen terlemah (misalnya, jika pembuangan yang lemah, ubah lokasi/tambah jumlah <i>safety box</i>).

d) Penyimpanan dan Transportasi Vaksin
Gambar 4.1.1.4 Penyimpanan dan Transportasi Vaksin



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata penyimpanan dan transportasi vaksin di bulan November 2025 sebesar 81,54% dan belum mencapai standart 80%.

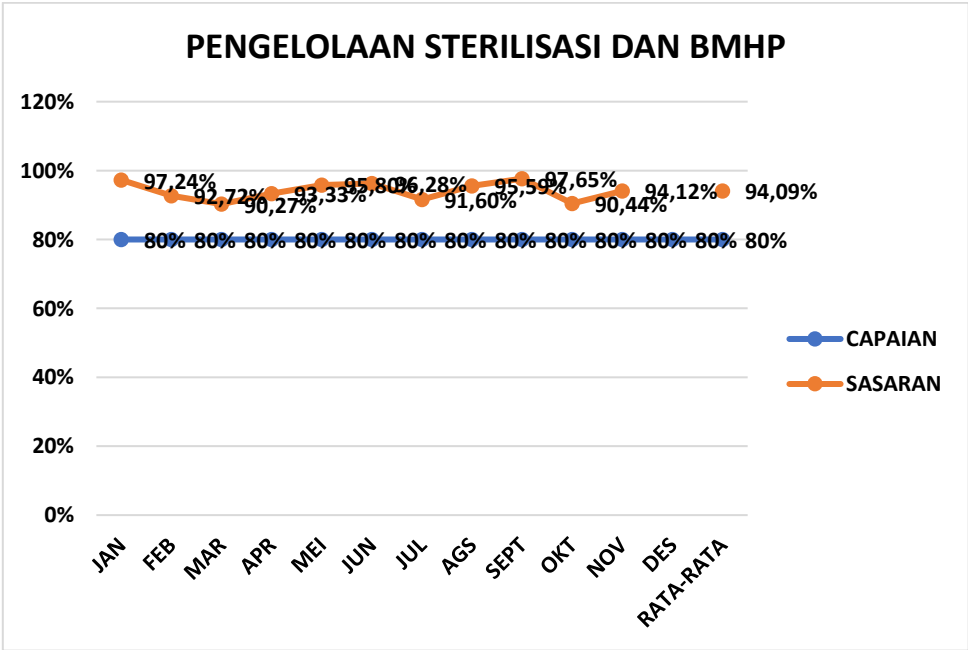
Tabel 4.1.1.4 Penyimpanan dan Transportasi Vaksin

PROBLEM	Kinerja belum stabil di 100% yang merupakan target ideal untuk menjaga kualitas vaksin.
STEP	Implementasi <i>Daily Cold Chain Checklist</i> dan Audit Transportasi: Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada dua titik kritis yang sering menjadi sumber kegagalan rantai dingin: 1. 2. Pengecekan Suhu Rutin (minimal 2 kali sehari) dan Standarisasi Prosedur Transportasi vaksin antar unit/fasilitas.
PLAN	1. 2. 3. Tujuan (Goal): Mencapai dan mempertahankan kepatuhan Penyimpanan dan Transportasi Vaksin secara konsisten di 100%. Tindakan (Implementasi): a. b. c. Desain dan terapkan <i>checklist</i> harian untuk mencatat suhu kulkas vaksin (pagi dan sore) serta tindakan korektif jika suhu di luar batas (+2°C - +8°C). Standardisasi pengisian <i>cool pack/ice pack</i> dan penggunaan <i>Vaccine Carrier</i> saat transportasi. Memberikan pelatihan ulang kepada staf yang bertanggung jawab pada rantai dingin (petugas farmasi/perawat imunisasi). Pengukuran: a. b. Indikator Proses: Persentase kelengkapan dan ketepatan pengisian <i>Daily Cold Chain Checklist</i>. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Penyimpanan dan Transportasi Vaksin bulanan (Sasaran).
DO	1. 2. Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur baru <i>checklist</i> dan transportasi. Menerapkan <i>Daily Cold Chain Checklist</i> di semua lokasi penyimpanan vaksin.

	3. Tim Pengawas/PPI melakukan <i>spot check</i> (audit) terhadap kulkas dan memeriksa kelengkapan <i>checklist</i> harian. 4. Melakukan audit observasi saat transportasi vaksin terjadi (apakah <i>cool pack</i> terisi penuh dan suhu terjaga).
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kelengkapan <i>Daily Cold Chain Checklist</i> dan kepatuhan prosedur transportasi. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 97,41%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah: a. Apakah ada masalah teknis pada alat pendingin (kulkas/freezer)? b. Apakah prosedur transportasi dilanggar karena buru-buru atau kurangnya <i>cool pack</i> yang siap pakai?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di 100%, standardisasikan <i>Daily Cold Chain Checklist</i> , masukkan ke dalam SPO, dan buat sistem eskalasi (pelaporan cepat) jika suhu diluar batas. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 100%. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan peralatan (misalnya, penggantian termometer yang tidak akurat, atau perbaikan kulkas) atau pada penyediaan logistik yang memadai (misalnya, menambah jumlah <i>cool pack</i>).

e) Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP

Gambar 4.1.1.5 Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata pengelolaan sterilisasi dan BMHP di bulan November 2025 sebesar 94,12% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.



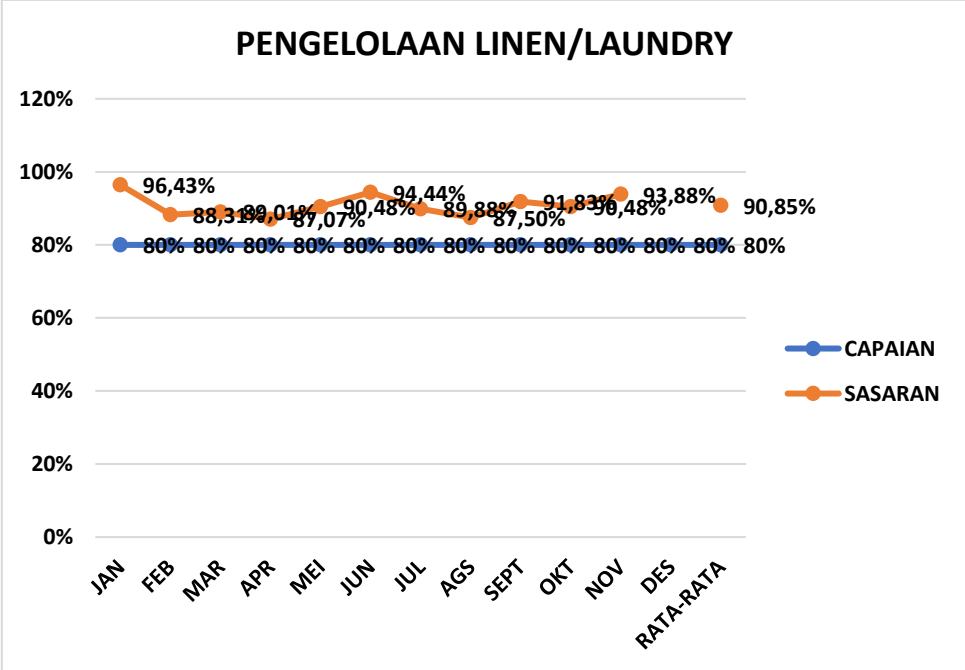
Tabel 4.1.1.5 Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP

PROBLEM	Kepatuhan terhadap Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP (Sasaran) menunjukkan fluktuasi, sempat turun di 90,44% (November). Kepatuhan belum stabil di atas 95% untuk menjamin kualitas instrumen dan material.
STEP	Audit Titik Kritis Pengendalian Kualitas (3 T): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan penurunan mutu: 1) Pengecekan Tanggal Kadaluarsa BMHP dan 2) Pencatatan/Verifikasi Ulang Tanda Indikator Sterilisasi pada setiap paket instrumen.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP agar mencapai minimal 95% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan sistem <i>double check</i> (dua orang) untuk pengecekan tanggal kadaluarsa BMHP sebelum didistribusikan ke unit pengguna. b. Menetapkan Checklist Serah Terima Instumen Steril yang mewajibkan pengguna (perawat/dokter) dan petugas CSSD memverifikasi <i>External Indicator</i> dan mencatatnya. c. Memberikan pelatihan ulang singkat kepada petugas CSSD dan perawat ruangan tentang manajemen stok BMHP dan <i>first-in, first-out</i> (FIFO) untuk BMHP. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Checklist Serah Terima Instumen Steril</i> . b. Indikator Proses: Persentase BMHP yang didistribusikan/digunakan dengan tanggal kadaluarsa yang valid. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur <i>double check</i> dan <i>checklist</i> baru. 2. Tim CSSD menerapkan <i>double check</i> kadaluarsa BMHP. 3. Petugas CSSD dan perawat ruangan wajib menggunakan Checklist Serah Terima Instumen Steril pada setiap penyerahan/penerimaan. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>double check</i> BMHP dan kepatuhan <i>checklist</i> .
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap <i>double check</i> BMHP dan kelengkapan <i>Checklist Serah Terima</i> . 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 94,09%).
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 95%, standardisasikan <i>Checklist Serah Terima Instumen Steril</i> dan prosedur <i>double check</i> BMHP ke seluruh unit pengguna. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah,

	modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan penyimpanan (misalnya, desain ulang rak penyimpanan agar stok lama mudah diakses untuk implementasi FIFO) atau pada validasi siklus sterilisasi (jika indikator sterilisasi masih menjadi masalah).
--	--

f) Pengelolaan Linen/Laundry

Gambar 4.1.1.6 Pengelolaan Linen/Laundry



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.6 diketahui bahwa rerata pengelolaan linen/laundry di bulan November 2025 sebesar 93,88% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

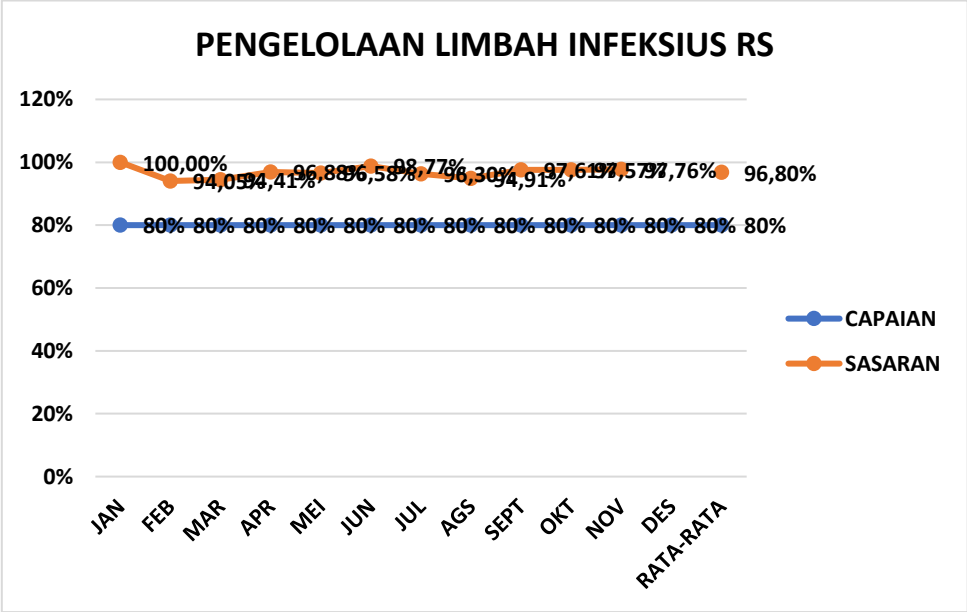
Tabel 4.1.1.6 Pengelolaan Linen/Laundry

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 93% untuk menjaga sterilitas dan mencegah penyebaran infeksi.
STEP	Audit Titik Kontaminasi Kritis (3 Zona): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan kontaminasi atau ketidakpatuhan: - Pemisahan Linen Kotor & Infeksius di unit, - Prosedur Serah Terima antara unit dan laundry, dan - Kondisi Area Penyimpanan Linen Bersih (bersih, kering, tertutup).
PLAN	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Linen/Laundry agar mencapai minimal 93% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Melakukan <i>coaching</i> ulang kepada staf perawat dan <i>cleaning service</i> di unit terkait tata cara pemilahan linen (kotor vs infeksius) dan pengisian kantong linen. - Menerapkan Checklist Harian Kondisi Linen Bersih di setiap unit (memastikan area penyimpanan bersih, tertutup, dan tidak lembap). - Standardisasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap oleh petugas <i>laundry</i> saat menangani linen kotor/infeksius.



	3. Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan pemisahan linen di unit. - Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Checklist Harian Kondisi Linen Bersih</i>. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Linen/Laundry bulanan (Sasaran).
DO	- Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur pemilahan dan pengisian <i>checklist</i> baru. - Unit-unit wajib mengisi Checklist Harian Kondisi Linen Bersih. - Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit-unit tentang cara pemilahan linen dan di area penyimpanan linen bersih. - Tim <i>Laundry</i> mencatat kepatuhan penggunaan APD.
STUDY	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap pemisahan linen dan kelengkapan <i>checklist</i> linen bersih. - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 90,85%). - Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah tempat penyimpanan linen kotor/infeksius tidak memadai (misalnya, jumlah troli kurang)? * Apakah petugas kesulitan mengosongkan linen kotor segera?
ACTION	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 93%, standardisasikan <i>Checklist Harian Kondisi Linen Bersih</i> dan prosedur pemilahan ke seluruh unit pengguna. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. - Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan infrastruktur/logistik (misalnya, menambah troli/kantong linen) atau pada desain ulang alur distribusi dari <i>laundry</i> ke unit untuk mencegah linen bersih terkontaminasi.

g) Pengelolaan Limbah Infeksius
Gambar 4.1.1.7 Pengelolaan Limbah Infeksius



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata pengelolaan limbah infeksius di bulan November 2025 sebesar 97,76% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

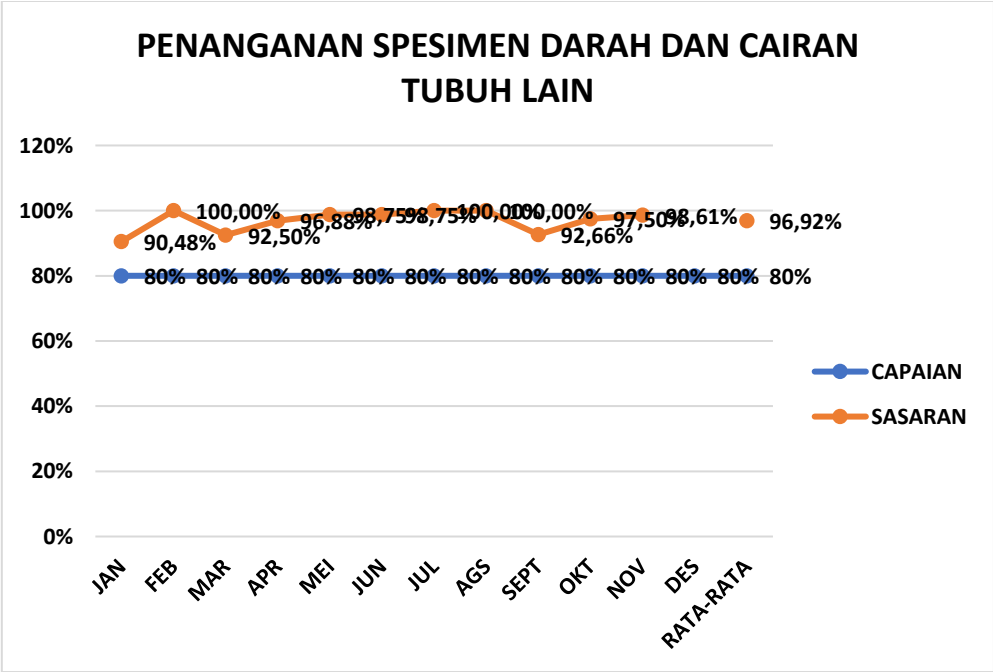
Tabel 4.1.1.7 Pengelolaan Limbah Infeksius

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil mendekati 100% untuk menjamin keamanan dan kepatuhan regulasi.
STEP	Implementasi Peringatan <i>Full-ness</i> dan Audit Penimbangan: Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada dua aspek kritis yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan atau tumpahan: - Pengisian Kantong Limbah Infeksius Tidak Melebihi $\frac{3}{4}$ Penuh dan - Pencatatan Penimbangan Limbah Tepat Waktu.
PLAN	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Limbah Infeksius agar mencapai minimal 97% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Memberikan pelatihan ulang kepada petugas <i>cleaning service</i> dan perawat mengenai batas pengisian kantong limbah (maksimal $\frac{3}{4}$) - Menerapkan Stiker/Tanda Visual di area penampungan sementara untuk menandai batas $\frac{3}{4}$ penuh pada troli/wadah. - Mewajibkan petugas yang mengangkut limbah mengisi Log Penimbangan di lokasi penampungan segera setelah limbah diangkut. - Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan pengisian kantong limbah (tidak melebihi $\frac{3}{4}$). - Indikator Proses: Persentase kelengkapan dan ketepatan pengisian Log Penimbangan Limbah. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Limbah Infeksius bulanan (Sasaran).

DO	- Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur batas pengisian dan pencatatan penimbangan. - Menerapkan Stiker/Tanda Visual batas 3/4 di unit-unit risiko tinggi. - Petugas kebersihan/transportasi wajib mengisi Log Penimbangan setiap kali limbah diangkut. - Tim Pengawas/Sanitarian melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit tentang batas pengisian kantong.
STUDY	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap batas 3/4 dan kelengkapan Log Penimbangan. - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 96,80%). - Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat:
ACTION	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 97%, standardisasikan penggunaan <i>Stiker/Tanda Visual</i> dan Log Penimbangan di seluruh unit. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil menunjukkan kepatuhan tertinggi. - Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan ketersediaan (misalnya, menambah stok kantong limbah) atau pada perbaikan infrastruktur (misalnya, memastikan tempat penampungan sementara mudah diakses oleh troli angkut).

h) Penanganan Spesimen Darah dan Cairan Tubuh Lain

Gambar 4.1.1.8 Penanganan Spesimen Darah dan Cairan Tubuh Lain



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.8 diketahui bahwa penanganan spesimen darah dan cairan tubuh lain di bulan November 2025 sebesar 98,61% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

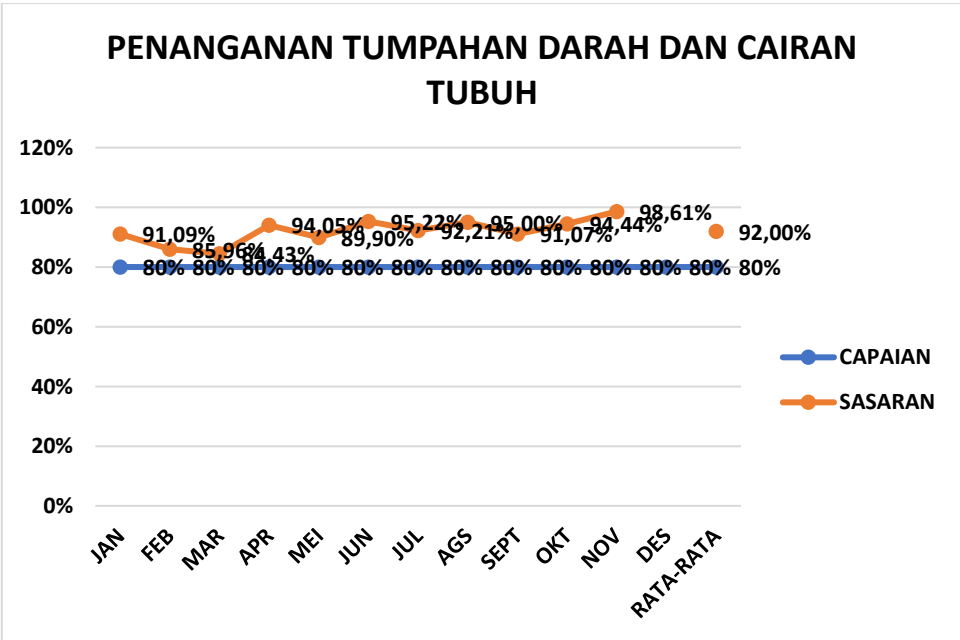


Tabel 4.1.1.8 Penanganan Spesimen Darah dan Cairan Tubuh Lain

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil mendekati 100% untuk menjamin keamanan staf dan integritas sampel.
STEP	Audit Titik Kontaminasi dan Identifikasi Kritis (3 K): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan: 1. Kelengkapan Labeling Spesimen yang akurat, 2. Kepatuhan Kebersihan Tangan dan APD saat mengambil/menangani spesimen, dan 3. Penggunaan Wadah Transportasi KEDAP yang benar.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Penanganan Spesimen hingga mencapai 100% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan Prosedur <i>Double Check Labeling</i> antara petugas pengambil sampel dan perawat/staf ruangan untuk memastikan identitas spesimen akurat. b. Menyediakan wadah transportasi spesimen yang standar, tertutup, dan anti bocor di semua unit. c. Memberikan <i>coaching</i> langsung (<i>on-the-spot coaching</i>) kepada staf terkait teknik penggunaan APD yang tepat saat mengambil sampel. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan dan keakuratan <i>labeling</i> spesimen. b. Indikator Proses: Persentase spesimen yang diangkut menggunakan wadah yang kedap/tertutup. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Penanganan Spesimen Darah dan Cairan Tubuh Lain bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur <i>double check labeling</i> dan penggunaan wadah kedap. 2. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit pengambilan sampel (IGD, Rawat Inap, Poliklinik) untuk kepatuhan APD dan <i>labeling</i> .
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap <i>double check labeling</i> dan penggunaan wadah kedap. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 96,92%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah ada kendala pada sistem pengiriman/transportasi yang menyebabkan spesimen tumpah? * Apakah petugas merasa terburu-buru dan melewatkan langkah <i>labeling</i> yang benar?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di 100%, standardisasikan prosedur <i>double check labeling</i> dan penggunaan wadah tertutup di seluruh unit. Masukkan prosedur ini ke dalam <i>job description</i> dan pelatihan orientasi. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil menunjukkan kepatuhan 100%. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan sistem (misalnya, memastikan

	ketersediaan wadah transportasi spesimen yang mudah dibawa dan bersih) atau pada integrasi teknologi untuk otomatisasi <i>labeling</i> spesimen.
--	---

- i) Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh
- Gambar 4.1.1.9 Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.9 diketahui bahwa penanganan spesimen darah dan cairan tubuh lain di bulan November 2025 sebesar 98,61% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.9 Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh

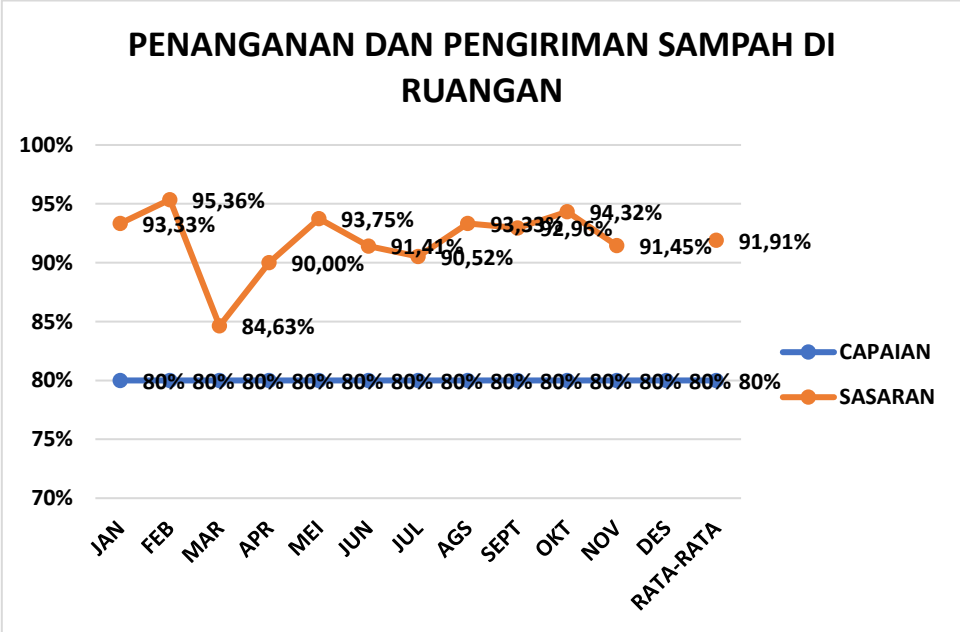
PROBLEM	Kepatuhan Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh (Sasaran) menunjukkan fluktuasi, sempat turun di 85,96% (Maret) dan 89,90% (Juni). Kepatuhan belum stabil di atas 94% yang merupakan target aman untuk meminimalkan risiko pajanan.
STEP	Implementasi <i>Spill Kit</i> Siap Pakai dan Pelatihan Simulasi: Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada dua aspek kritis: - Ketersediaan dan Kelengkapan <i>Spill Kit</i> di unit berisiko tinggi dan - Kecepatan dan Ketepatan Penggunaan APD serta prosedur saat terjadi tumpahan.
PLAN	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh hingga mencapai minimal 94% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Audit dan standarisasi isi <i>Spill Kit</i> (misalnya, disinfektan konsentrasi tinggi, APD, bahan penyerap, alat pengangkut) di unit berisiko tinggi (IGD, Kamar Operasi, Laboratorium). - Memberikan pelatihan simulasi singkat (<i>drill</i>) kepada staf dan <i>cleaning service</i> tentang prosedur penanganan tumpahan yang benar. - Menerapkan <i>checklist</i> pengecekan <i>Spill Kit</i> harian/mingguan untuk memastikan kelengkapan dan



	tidak kadaluarsa. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase ketersediaan dan kelengkapan <i>Spill Kit</i> di unit. b. Indikator Proses: Persentase staf yang mampu mendemonstrasikan prosedur penanganan tumpahan yang benar. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Penanganan Tumpahan Darah dan Cairan Tubuh bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan simulasi penanganan tumpahan kepada staf inti di unit uji coba. 2. Melakukan audit dan mengisi Checklist Kelengkapan <i>Spill Kit</i> secara berkala. 3. Tim Pengawas/PPI melakukan <i>spot check</i> di unit untuk memverifikasi lokasi dan kelengkapan <i>Spill Kit</i>.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase ketersediaan <i>Spill Kit</i> dan kemampuan staf dalam mendemonstrasikan prosedur. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 92,00%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah lokasi <i>Spill Kit</i> tidak strategis? * Apakah staf yang bertugas menangani tumpahan (misalnya, <i>cleaning service</i>) belum mendapat pelatihan yang memadai?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 94%, standardisasikan isi <i>Spill Kit</i> dan wajibkan pelatihan <i>drill</i> penanganan tumpahan secara rutin minimal setiap 6 bulan. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada penyediaan logistik (misalnya, <i>Spill Kit</i> yang lebih <i>user-friendly</i>) atau pada pembuatan SOP bergambar yang jelas dan mudah diakses di area berisiko tinggi.

j) Penanganan dan Pengiriman Sampah di Ruangan

Gambar 4.1.1.10 Penanganan dan Pengiriman Sampah di Ruangan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.10 diketahui bahwa penanganan spesimen dan pengiriman sampah di ruangan di bulan November 2025 sebesar 91,45% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

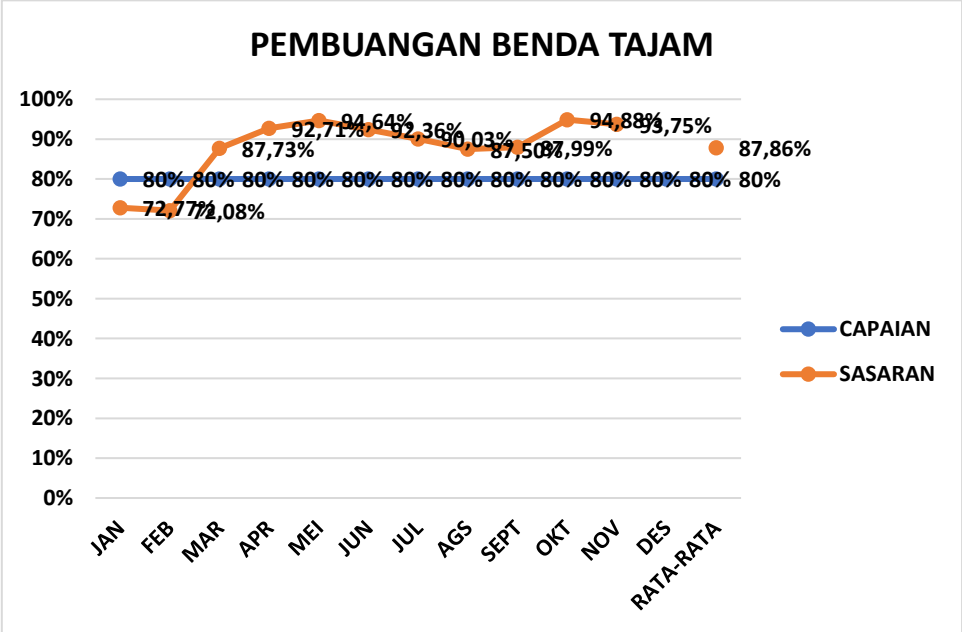
Tabel 4.1.1.10 Penanganan dan Pengiriman Sampah di Ruangan

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 93% untuk memastikan prosedur kebersihan dilaksanakan secara optimal.
STEP	Implementasi Pemilahan Sederhana 3 Warna dan Jadwal Pengangkutan Ketat (3P): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis: - Pemilahan Sampah Sesuai Warna (Infeksius, Non-Infeksius, Benda Tajam), - Penggunaan APD oleh petugas saat mengangkut sampah, dan - Kepatuhan Jadwal Pengiriman dari ruangan ke TPS.
PLAN	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Penanganan dan Pengiriman Sampah hingga mencapai minimal 93% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Memberikan pelatihan ulang kepada seluruh staf (perawat dan <i>cleaning service</i>) di ruangan tentang standar pemilahan sampah berdasarkan warna. - Menerapkan Poster/Stiker Visual di dekat tempat sampah untuk mengingatkan pemilahan dan batas pengisian. - Menetapkan Jadwal Pengangkutan Sampah yang Ketat dari ruangan (misalnya, 3 kali sehari) dan mewajibkan petugas mencatat waktu serah terima. - Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan pemilahan sampah di ruangan. - Indikator Proses: Persentase kelengkapan pengisian log serah terima/pengangkutan sampah. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Penanganan dan Pengiriman Sampah di Ruangan bulanan (Sasaran).

DO	- Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur pemilahan dan jadwal pengiriman. - Menempelkan Poster/Stiker Visual di unit-unit uji coba. - Petugas <i>cleaning service</i> dan perawat ruangan wajib mematuhi jadwal pengiriman dan mencatat serah terima. - Tim Pengawas/Sanitarian melakukan audit observasi <i>spot check</i> pemilahan sampah (memeriksa isi kantong) dan memverifikasi log pengiriman.
STUDY	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap pemilahan dan pengisian log. - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 91,91%). - Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah tempat sampah di ruangan tidak memadai (misalnya, kurangnya tempat sampah sesuai warna)? * Apakah petugas kesulitan menaati jadwal pengiriman karena alasan lain?
ACTION	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 93%, standardisasikan prosedur pemilahan sampah berdasarkan visual (stiker/poster) dan Log Serah Terima Pengiriman ke seluruh unit. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. - Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan infrastruktur (misalnya, memastikan jumlah dan jenis tempat sampah yang sesuai tersedia di setiap titik) atau pada integrasi pemantauan (misalnya, pengawasan CCTV di area pengumpulan sementara).

k) Pembuangan Benda Tajam

Gambar 4.1.1.11 Pembuangan Benda Tajam



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.11 diketahui pembuangan benda tajam di bulan November 2025 sebesar 93,75% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

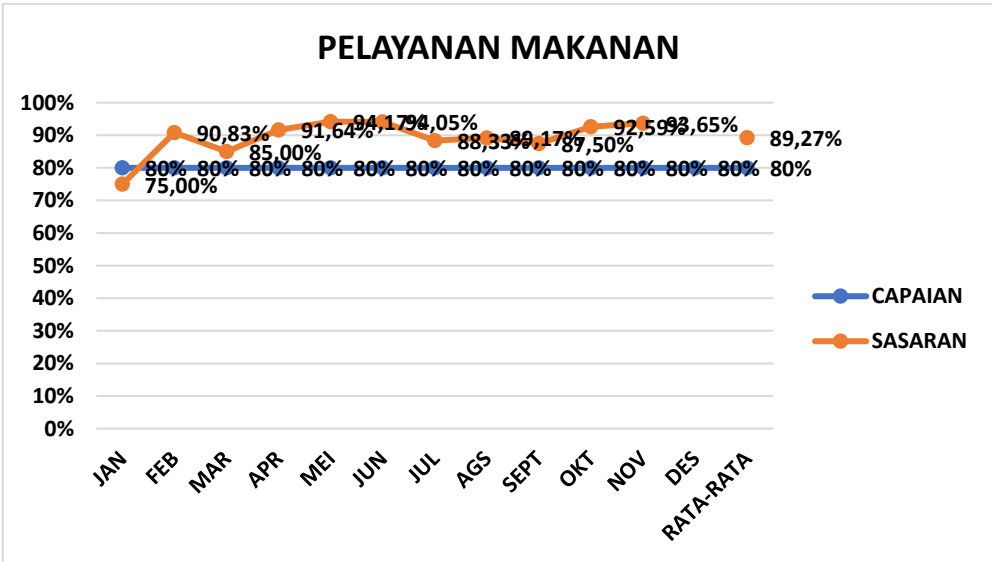


Tabel 4.1.1.11 Pembuangan Benda Tajam

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 90%, yang berpotensi meningkatkan risiko insiden tertusuk jarum.
STEP	Implementasi <i>Akses Segera</i> dan Peringatan Kritis <i>Safety Box</i> : Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada dua aspek kritis: 1) Penempatan <i>Safety Box</i> yang mudah dijangkau dan 2) Penggantian <i>Safety Box</i> Tepat Waktu (Tidak Melebihi 3/4 Penuh).
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pembuangan Benda Tajam hingga mencapai minimal 90% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Audit dan reposisi <i>Safety Box</i> di unit berisiko tinggi (misalnya, IGD, ICU, Rawat Inap) agar jaraknya tidak lebih dari 1 meter dari titik penggunaan. b. Menerapkan Prosedur <i>Visual Check</i> harian oleh perawat/petugas kebersihan untuk memverifikasi level isi <i>Safety Box</i> tidak melebihi batas 3/4 c. Memberikan pelatihan simulasi singkat kepada staf tentang prosedur pembuangan satu tangan dan batas 3/4 3. Pengukuran: * Indikator Proses: Persentase <i>Safety Box</i> yang ditempatkan sesuai standar jarak (<1m). * Indikator Proses: Persentase <i>Safety Box</i> yang diganti tepat waktu (tidak melebihi 3/4 penuh). * Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pembuangan Benda Tajam bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan simulasi dan sosialisasi prosedur batas pengisian dan penempatan. 2. Tim Pengawas/PPI melakukan audit dan mengisi Checklist Penempatan <i>Safety Box</i>. 3. Petugas ruangan/kebersihan wajib melakukan <i>visual check</i> batas pengisian 3/4 setiap <i>shift</i>. 4. Melakukan penggantian <i>Safety Box</i> di semua lokasi yang melebihi batas 3/4
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap penempatan <i>Safety Box</i> dan penggantian tepat waktu. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 87,86%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah ada kendala logistik dalam pengadaan/distribusi <i>Safety Box</i> baru? * Apakah penempatan <i>Safety Box</i> mengganggu alur kerja?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 90%, standardisasikan prosedur penempatan (<1m) dan prosedur penggantian <i>Safety Box</i> batas ¾. Masukkan prosedur ini ke dalam <i>Patient Safety Rounds</i>. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan sistem (misalnya, membuat sistem permintaan <i>Safety Box</i> yang lebih cepat) atau pada penggunaan jarum berfitur pengaman (<i>safety engineered</i>

devices) di area berisiko tinggi.

I) Pelayanan Makanan
Gambar 4.1.1.12 Pelayanan Makanan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.12 diketahui pelayanan makanan pada bulan November 2025 sebesar 93,65% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

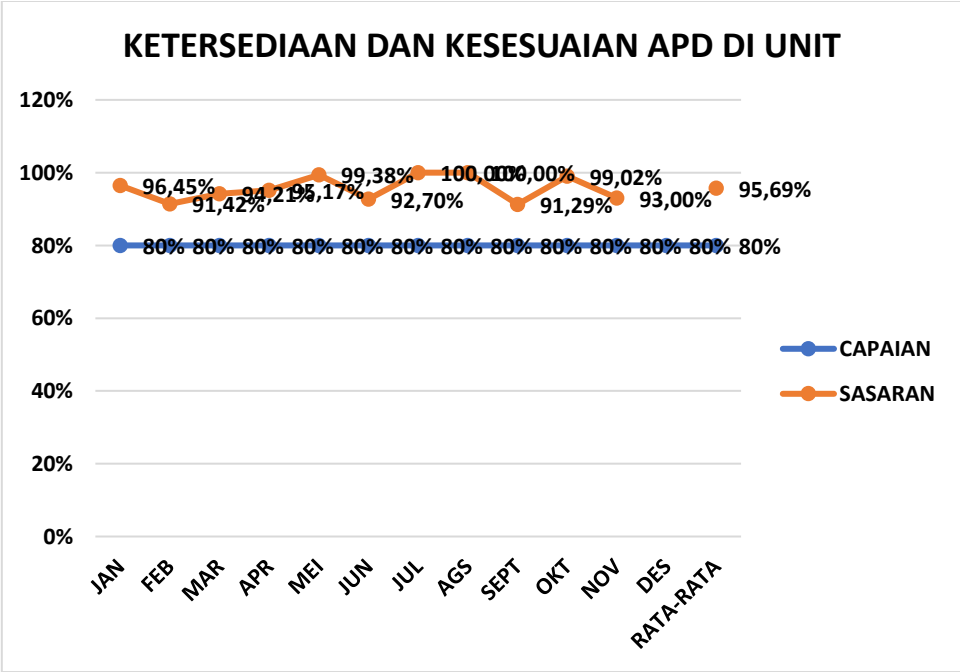
Tabel 4.1.1.12 Pelayanan Makanan

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 92% untuk menjamin keamanan, ketepatan, dan kualitas makanan pasien.
STEP	Implementasi <i>Time-Out</i> Verifikasi dan Audit Suhu (2T): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada dua aspek kritis yang berkaitan dengan keamanan dan ketepatan: 1. Verifikasi Ketepatan Diet dan Identitas Pasien sebelum penyajian dan 2. Pengendalian Suhu Makanan panas > 60oC atau dingin <4oC saat disajikan
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pelayanan Makanan hingga mencapai minimal 92% secara konsisten dan menghilangkan insiden di bawah target. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan Prosedur <i>Time-Out</i> Makanan di <i>pantry</i> ruangan: Petugas verifikasi (perawat/pramusaji) membaca dan mencocokkan diet, nama pasien, dan kamar sebelum tray dikeluarkan. b. Mewajibkan pencatatan Suhu Makanan (<i>food temperature</i>) pada <i>tray</i> sampel atau di titik penyajian oleh petugas. c. Memberikan pelatihan ulang kepada petugas penyaji makanan terkait prinsip <i>Hygienic Food Handling</i> . 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Time-Out</i> Verifikasi (Ketepatan diet dan identitas). b. Indikator Proses: Persentase makanan yang disajikan sesuai standar suhu > 60°C atau dingin <4°C c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pelayanan Makanan bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur <i>Time-Out</i> dan

	pengukuran suhu. 2. Menerapkan Prosedur <i>Time-Out</i> Makanan di unit uji coba sebelum distribusi <i>tray</i>. 3. Petugas penyaji wajib mengukur suhu dan mencatatnya. 4. Tim Pengawas/Gizi melakukan audit observasi <i>spot check</i> di <i>pantry</i> ruangan (memverifikasi <i>Time-Out</i>) dan mengukur suhu makanan saat disajikan.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap <i>Time-Out</i> dan pemenuhan standar suhu. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 89,27%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah proses verifikasi terlalu lama sehingga makanan menjadi dingin? * Apakah peralatan penyaji/penghangat (<i>food warmer</i>) tidak berfungsi optimal?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 92%, standardisasikan Prosedur <i>Time-Out</i> Makanan dan pencatatan suhu di seluruh unit. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan peralatan (misalnya, perbaikan <i>food warmer</i> atau penggantian <i>thermometer</i> yang akurat) atau pada desain ulang alur distribusi dari dapur ke ruangan untuk mengurangi waktu tunggu.

m) Ketersediaan dan Kesesuaian APD di Unit

Gambar 4.1.1.13 Ketersediaan dan Kesesuaian APD di Unit



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.12 diketahui ketersediaan dan kesesuaian APD di Unit pada bulan November 2025 sebesar 93,00% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.



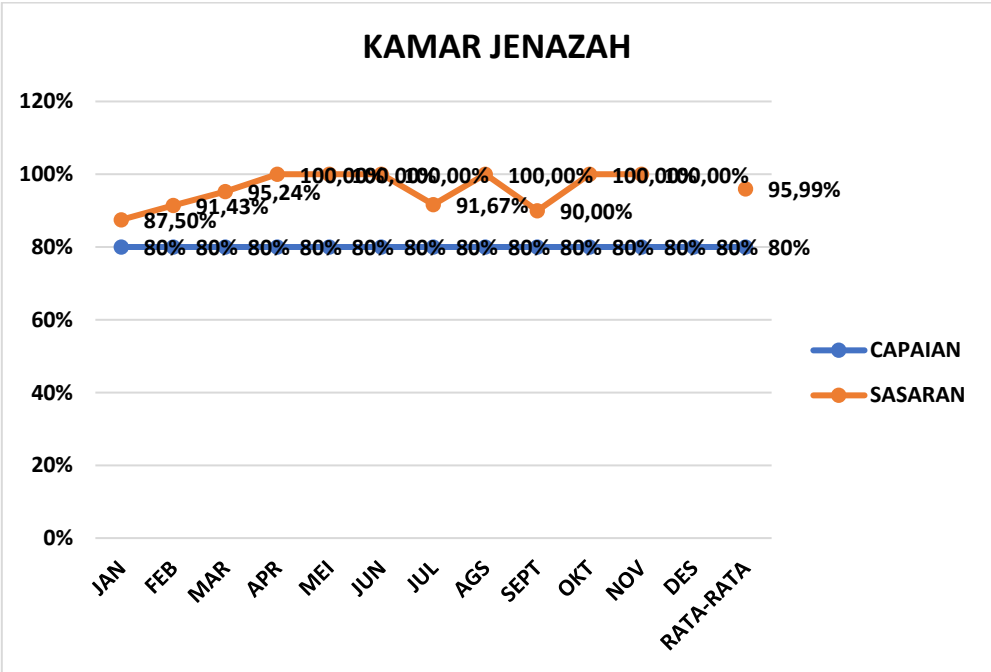
Tabel 4.1.1.13 Ketersediaan dan Kesesuaian APD di Unit

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 99% untuk menjamin keamanan staf dari risiko pajanan.
STEP	Implementasi <i>Daily Check</i> APD dan Pemenuhan Stoker: Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada dua aspek kritis: 1) Pengecekan Ketersediaan APD (jenis dan jumlah) di troli/lemari APD setiap <i>shift</i> dan 2) Pemenuhan Stok Harian yang wajib diisi oleh petugas logistik/perbekalan.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Mencapai dan mempertahankan kepatuhan Ketersediaan dan Kesesuaian APD secara konsisten di 100%. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan Checklist Pengecekan APD Harian yang wajib diisi oleh kepala <i>shift</i> di setiap unit. b. Menetapkan Level Stok Minimum (par) untuk setiap jenis APD (masker, sarung tangan, gaun, dll.) di setiap unit. c. Memberikan pelatihan ulang kepada petugas logistik/farmasi mengenai sistem pengisian stok APD berdasarkan Level Stok Minimum. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan pengisian <i>Checklist Pengecekan APD Harian</i>. b. Indikator Proses: Persentase item APD yang tersedia di atas Level Stok Minimum. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Ketersediaan dan Kesesuaian APD bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur <i>checklist</i> dan Level Stok Minimum. 2. Kepala <i>shift</i> wajib mengisi Checklist Pengecekan APD Harian. 3. Petugas logistik/farmasi wajib mengisi stok APD di unit sesuai Level Stok Minimum. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit untuk memverifikasi kesesuaian antara <i>checklist</i> dan kondisi APD aktual.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kelengkapan <i>Checklist Harian</i> dan kepatuhan pengisian stok. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 95,69%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah sistem permintaan APD dari unit ke gudang terlalu rumit? * Apakah APD yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di unit tersebut?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di 100%, standardisasikan penggunaan <i>Checklist Pengecekan APD Harian</i> dan prosedur pengisian stok berdasarkan Level Stok Minimum. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil menunjukkan kepatuhan 100%. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem logistik (misalnya, membuat sistem permintaan <i>online</i> yang terintegrasi) atau pada audit kesesuaian (memastikan jenis APD yang disediakan memang

	yang paling sesuai dan dibutuhkan unit).
--	--

n) Kamar Jenazah

Gambar 4.1.1.14 Kamar Jenazah



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.14 diketahui kamar jenazah di Unit pada bulan November 2025 sebesar 100% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

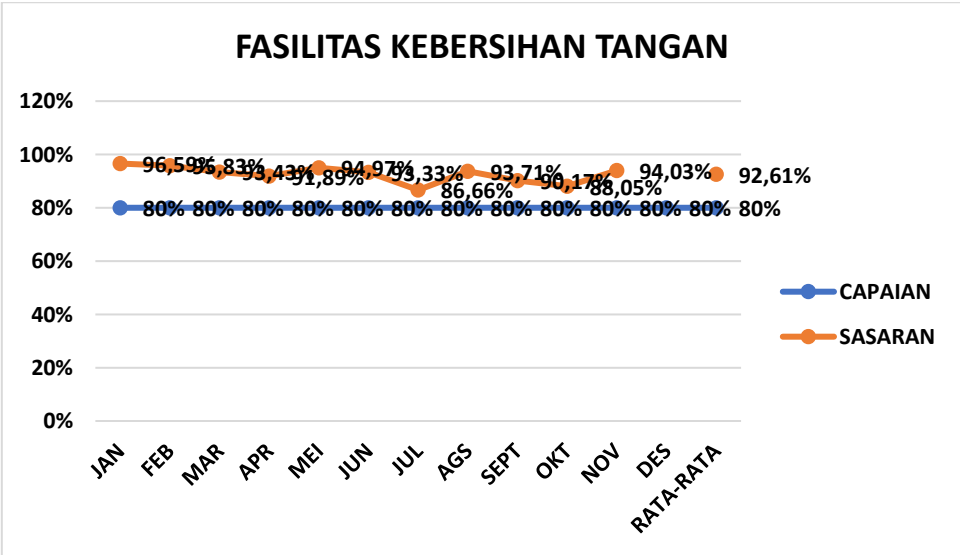
Tabel 4.1.1.14 Kamar Jenazah

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil mendekati 100%, yang vital untuk menjaga martabat pasien dan keamanan petugas.
STEP	Audit Titik Kritis Penanganan Jenazah Infeksius (3P): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan: 1) Penggunaan APD Lengkap oleh petugas, 2) Prosedur Pembungkusan/Labeling Jenazah yang tepat (terutama jenazah infeksius), dan 3) Pembersihan dan Desinfeksi <i>Brankar</i> dan Meja Perawatan setelah digunakan
PLAN	1. Tujuan (Goal): Mencapai dan mempertahankan kepatuhan Pengelolaan Kamar Jenazah secara konsisten di 100%. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan Checklist Penggunaan APD dan Penanganan Jenazah yang wajib diisi oleh petugas kamar jenazah untuk setiap jenazah yang masuk/keluar. b. Menyediakan APD Khusus dan Kit Pembungkus Jenazah (termasuk label infeksius) yang mudah diakses di kamar jenazah. c. Memberikan pelatihan simulasi kepada petugas kamar jenazah terkait prosedur <i>double-bagging</i> dan dekontaminasi pasca-penggunaan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan pengisian <i>Checklist APD dan Pembungkusan</i>. b. Indikator Proses: Persentase kebersihan area dan

	peralatan pasca-penggunaan (dievaluasi melalui <i>spot check</i>). c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Kamar Jenazah bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan simulasi dan sosialisasi prosedur <i>checklist</i> baru. 2. Petugas kamar jenazah wajib mengisi Checklist APD dan Pembungkusan untuk setiap kasus. 3. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>spot check</i> di kamar jenazah untuk memverifikasi kepatuhan APD dan kebersihan alat/area.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kelengkapan <i>Checklist</i> dan kepatuhan penggunaan APD/desinfeksi. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 95,99%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah APD tidak tersedia dalam ukuran yang tepat? * Apakah petugas merasa terburu-buru atau kelelahan sehingga melewati langkah desinfeksi?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di 100%, standardisasikan penggunaan <i>Checklist APD dan Pembungkusan</i> dan prosedur desinfeksi <i>terminal</i> . Masukkan pelatihan simulasi sebagai jadwal rutin. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif kepada petugas yang menunjukkan kepatuhan 100%. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan infrastruktur (misalnya, memastikan ventilasi yang memadai atau ketersediaan air panas) atau pada penyediaan APD yang lebih ergonomis dan <i>user-friendly</i> .

o) Fasilitas Kebersihan Tangan

Gambar 4.1.1.15 Fasilitas Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.15 diketahui fasilitas kebersihan tangan di Unit pada bulan November 2025 sebesar 94,03% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.



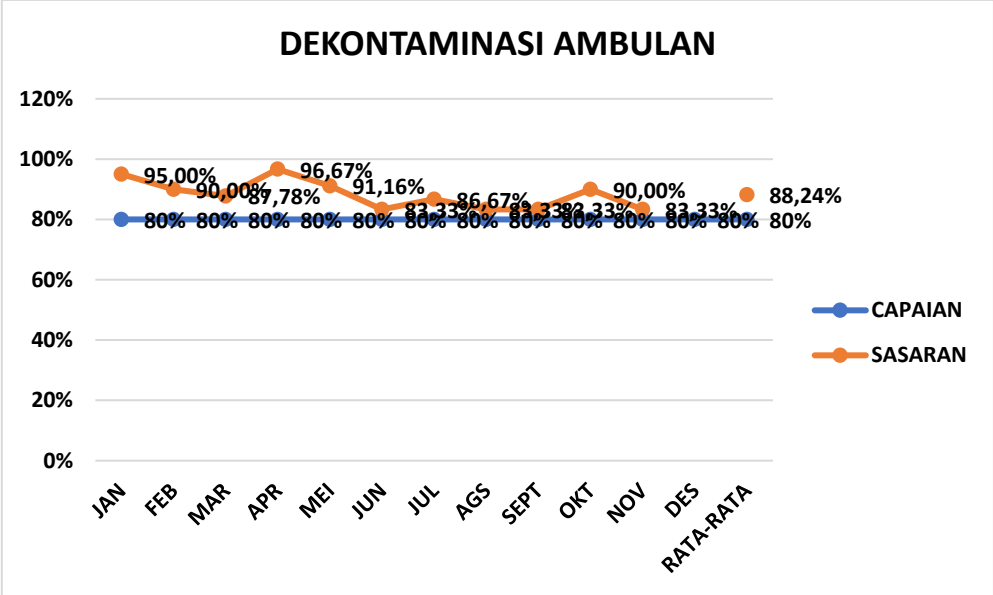
Tabel 4.1.1.15 Fasilitas Kebersihan Tangan

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 95% untuk mendukung program pencegahan infeksi.
STEP	Implementasi Audit Sederhana 3 Elemen Kritis (3E): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang sering menjadi penyebab kegagalan: 1. Ketersediaan <i>Handrub</i> dan 2. Ketersediaan Sabun/Air Mengalir, dan 3) Kondisi <i>Dispenser</i> (berfungsi dan tidak bocor).
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Ketersediaan Fasilitas Kebersihan Tangan hingga mencapai minimal 95% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan Checklist Audit Ketersediaan 3E (Handrub, Sabun/Air, Dispenser Berfungsi) yang wajib diisi oleh kepala <i>shift</i> atau petugas kebersihan minimal 2 kali sehari. b. Menetapkan Prosedur Pelaporan Cepat (<i>fast-track reporting</i>) kepada teknisi/logistik jika ditemukan dispenser rusak atau <i>handrub</i> habis. c. Memberikan pelatihan ulang kepada petugas logistik dan <i>cleaning service</i> mengenai <i>stock management</i> dan pengisian ulang <i>handrub</i> /sabun. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan pengisian <i>Checklist Audit Ketersediaan 3E</i> . b. Indikator Proses: Rata-rata waktu respons perbaikan fasilitas yang rusak (misalnya, dispenser). c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Ketersediaan Fasilitas Kebersihan Tangan bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur <i>checklist</i> dan pelaporan cepat. 2. Kepala <i>shift</i> wajib mengisi Checklist Audit Ketersediaan 3E. 3. Petugas <i>cleaning service</i> wajib segera melaporkan jika <i>handrub</i> habis atau dispenser rusak. 4. Tim Pengawas melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit untuk memverifikasi ketersediaan dan fungsi fasilitas.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kelengkapan <i>Checklist</i> dan kepatuhan pelaporan cepat. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 92,61%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah <i>handrub</i> yang tersedia tidak disukai staf (bau/tekstur)? * Apakah proses pengadaan/distribusi <i>handrub</i> sering terlambat?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 95%, standardisasikan penggunaan <i>Checklist Audit Ketersediaan 3E</i> dan prosedur pelaporan cepat. Masukkan <i>maintenance</i> fasilitas kebersihan tangan sebagai prioritas harian. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil menunjukkan kepatuhan 100%. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah,

	modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan sistem (misalnya, menjamin ketersediaan <i>handrub</i> dengan membuat kontrak jangka panjang) atau pada peningkatan kualitas <i>handrub</i> (jika faktor penerimaan staf menjadi masalah).
--	---

p) Dekontaminasi Ambulan

Gambar 4.1.1.16 Dekontaminasi Ambulan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.16 diketahui dekontaminasi ambulan pada bulan November 2025 sebesar 83,33% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

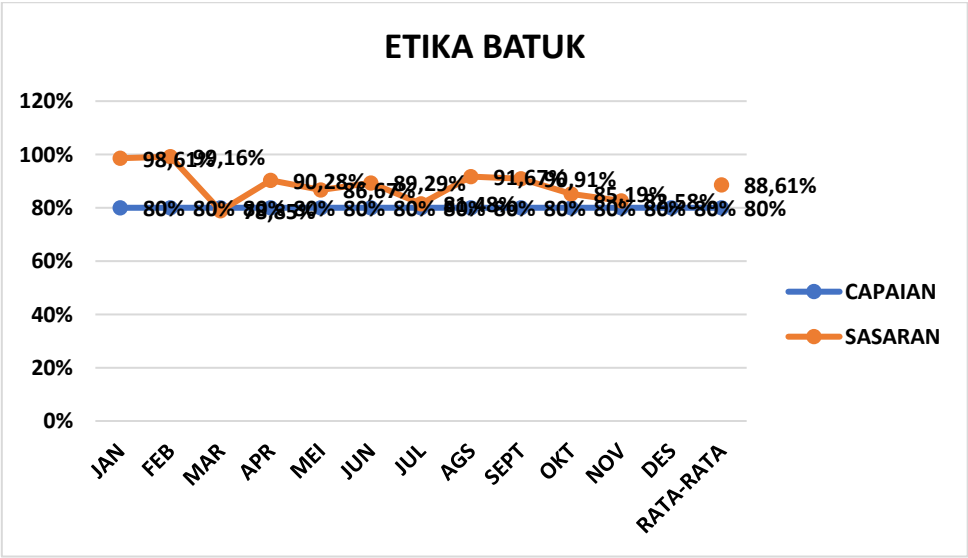
Tabel 4.1.1.16 Dekontaminasi Ambulan

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 90% untuk menjamin lingkungan yang steril dan aman bagi pasien dan petugas.
STEP	Implementasi <i>Checklist</i> dan Audit Cepat Pasca-Penggunaan (3C): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis: - Pengecekan Ketersediaan Disinfektan yang tepat, - Prosedur Pembersihan Area Vital (lantai, pegangan pintu, dan peralatan), dan - Pengisian <i>Checklist</i> Pasca-Transportasi (setiap selesai mengangkut pasien).
PLAN	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Dekontaminasi Ambulan hingga mencapai minimal 90% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Menerapkan <i>Checklist</i> Dekontaminasi Ambulan yang wajib diisi oleh petugas ambulan setiap selesai penggunaan, dengan fokus pada area yang sering tersentuh. - Menetapkan <i>Prosedur Visual Audit</i> Mendadak oleh pengawas/tim PPI di area <i>drop-off</i> ambulan untuk memverifikasi prosedur dekontaminasi. - Memberikan pelatihan ulang kepada petugas ambulan terkait jenis dan konsentrasi disinfektan yang digunakan (misalnya, klorin 0,5%).

	3. Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kelengkapan pengisian <i>Checklist Dekontaminasi Ambulan</i> pasca-penggunaan. - Indikator Proses: Persentase ketersediaan disinfektan yang sesuai standar. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Dekontaminasi Ambulan (Sasaran) bulanan/triwulan.
DO	1. Petugas ambulan wajib mengisi Checklist Dekontaminasi Ambulan setelah setiap pasien. 2. Tim Pengawas melakukan audit observasi <i>spot check</i> (misalnya, 5 kali per minggu) untuk memverifikasi proses dan hasil dekontaminasi.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kelengkapan <i>Checklist</i> dan kepatuhan penggunaan disinfektan. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada periode uji coba dengan data dasar (rata-rata TWIII 88,24%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah <i>checklist</i> terlalu panjang atau tidak praktis di lapangan? * Apakah petugas ambulan sering terburu-buru merespons panggilan berikutnya?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 90%, standardisasikan penggunaan <i>Checklist Dekontaminasi Ambulan</i> dan prosedur <i>fast-track</i> pengisian logistik (misalnya, disinfektan dan APD). 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif kepada tim yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem/manajemen waktu (misalnya, menambah waktu <i>buffer</i> antar panggilan untuk dekontaminasi) atau pada penyediaan <i>pre-mixed disinfectant</i> yang siap pakai.

q) Etika Batuk

Gambar 4.1.1.17 Etika Batuk



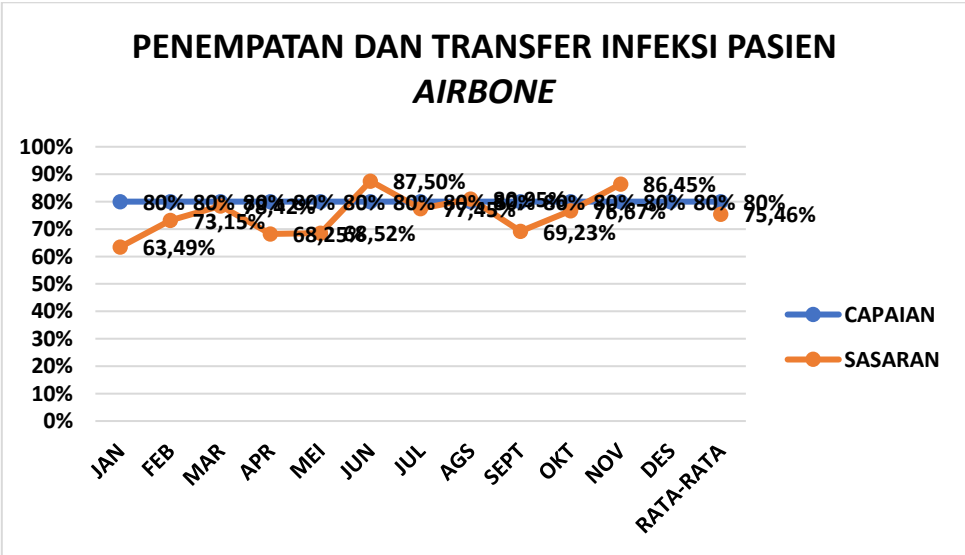
Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.17 diketahui etika batuk pada bulan November 2025 sebesar 82,58% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.



Tabel 4.1.1.17 Etika Batuk

PROBLEM	Kepatuhan belum stabil di atas 90%, yang penting untuk pencegahan transmisi infeksi pernapasan.
STEP	Edukasi <i>High-Impact</i> dan Pemasangan Media Visual Kritis (3M): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis: 1) Pemasangan Media Visual (Poster) di area berisiko tinggi (misalnya, Poliklinik, IGD), 2) <i>Coaching</i> Langsung (<i>role-model</i>) oleh staf senior, dan 3) Ketersediaan Tisu dan Tempat Sampah Tertutup yang memadai.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Etika Batuk hingga mencapai minimal 90% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Desain dan cetak poster/stiker sederhana bergambar tentang Etika Batuk. b. Pemasangan poster/stiker tersebut di area tunggu pasien, pintu masuk, dan area <i>triase</i>. c. Menerapkan Prosedur <i>Buddy Coaching</i>: Staf senior (<i>role-model</i>) wajib memberikan <i>coaching</i> singkat kepada staf dan pasien/pengunjung yang terlihat tidak patuh. d. Audit ketersediaan tisu dan tempat sampah tertutup di area publik. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase ketersediaan media visual (poster/stiker). b. Indikator Proses: Persentase ketersediaan tisu dan tempat sampah tertutup. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Etika Batuk bulanan (Sasaran).
DO	1. Melakukan sosialisasi pemasangan media visual. 2. Memasang poster/stiker di lokasi yang telah ditentukan. 3. Menerapkan prosedur <i>Buddy Coaching</i> di unit-unit berisiko. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi langsung <i>spot check</i> di area publik untuk memverifikasi kepatuhan staf/pasien dan ketersediaan fasilitas.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase ketersediaan media visual dan fasilitas. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar (rata-rata 88,61%). 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah pasien/pengunjung tidak mengerti bahasa pada poster? * Apakah <i>Buddy Coaching</i> tidak dilakukan secara konsisten?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 90%, standardisasikan penggunaan media visual dan prosedur <i>Buddy Coaching</i> sebagai bagian dari budaya keselamatan. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada pendekatan edukasi yang berbeda (misalnya, menggunakan video singkat di area tunggu) atau pada peningkatan intensitas <i>coaching</i> di area <i>triase</i> pasien.

- b. Kewaspadaan Transmisi
- a) Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien Airbone
- Gambar 4.1.1.3 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien Airbone



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer infeksi pasien *airbone* di bulan November 2025 sebesar 76,67% dengan rerata yang belum mencapai standart 80%.

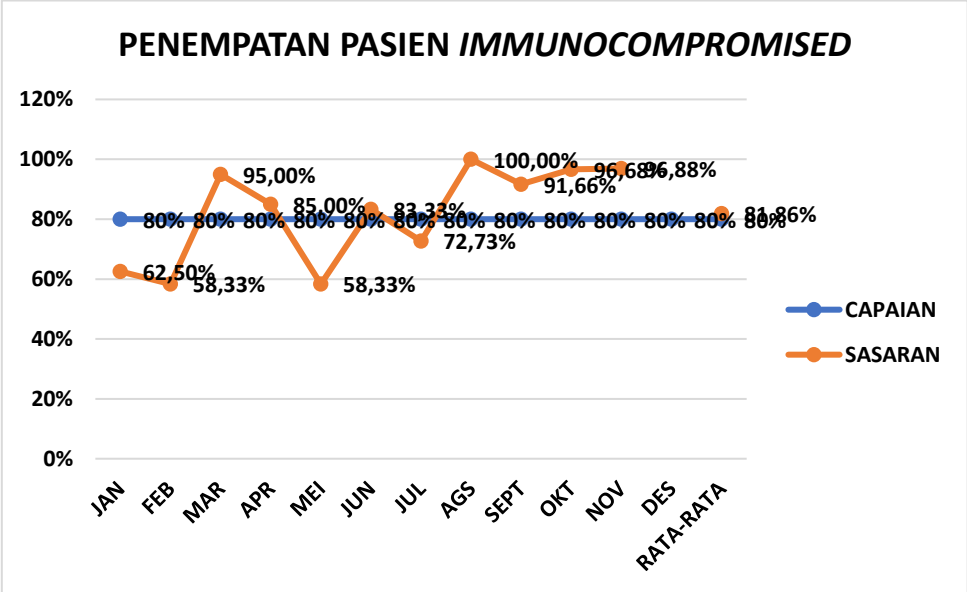
Tabel 4.1.1.3 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien Airbone

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkesi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan dan transfer pasien dengan infeksi airborne agar mencapai target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial ; b. Kurangnya pemahaman staff mengenai prosedur airborne precaution c. Tidak semua ruang perawatan dilengkapi system isolasi airborne d. Koordinasi antar unit dalam proses transfer masih lemahn 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan.



	b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sesuai dengan SOP dan standart yang berlaku c. Koordinasi dengan IPCLN melalui grub komunikasi aktif di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 86,45% dengan rerata capaian 75,46% dan belum mencapai target 80%, 2. Monitoring kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dilakukan secara mingguan 3. Evaluasi dilakukan terhadap proses transfer yang terjadi setiap bulan 4. Lakukan audit terhadap dokumentasi penempatan pasien
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. 2. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 3. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi, 4. Perkuat system pemantauan dan laporan internal 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat

b) Penempatan Pasien *Immunocomprissed*
Gambar 4.1.1.4 Penempatan Pasien *Immunocomprissed*



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien *immunocomprissed* di bulan November 2025 sebesar 96,88% dengan rerata sudah mencapai standart 80%.

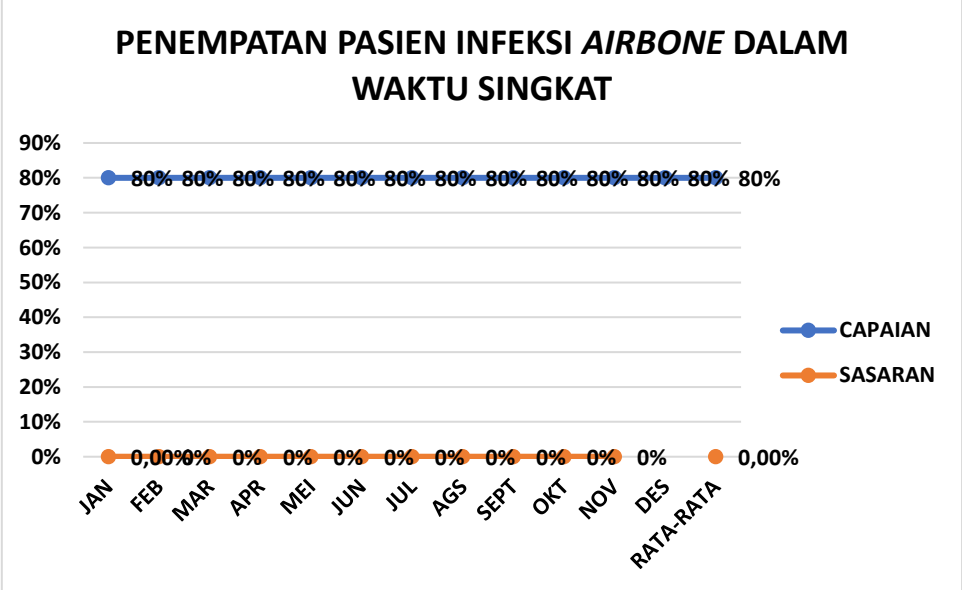
Tabel 4.1.1.4 Penempatan Pasien *Immunocomprissed*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> belum mencapai 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan pasien immunocompromised sesuai standart dengan target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial; b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya penempatan khusus bagi pasien immunocompromised c. fasilitas ruang isoalsi terbatas d. kelemahan dalam system triase awal dan komunikasi lintas unit 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprissed</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi



	tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> terhadap proses triase d. Optimalisasi ruang perawatan dengan system kohorting pasien sejenis
DO	Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 96,88% dengan rerata 81,86% dan sudah mencapai standart 80%. 2. Lakukan audit internal mingguan terhadap dokumentasi dan praktik penempatan 3. Data dievaluasi untuk melihat perbaikan dan hambatan dalam proses 4. Lakukan pembahasan secara rutin dalam rapat koordinasi
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>. 2. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 3. Evaluasi keberlanjutan program setiap 3 bulan dan perbaikan berkelanjutan 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>

- c) Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat
- Gambar 4.1.1.5 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan November 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.5 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat

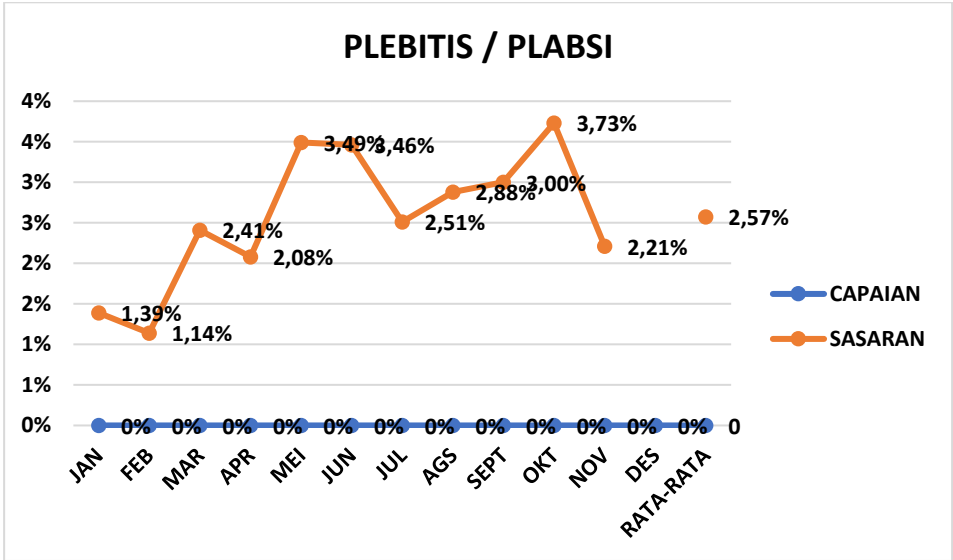


	baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 0%, 2. Ditemukan data sebesar 0% dikarenakan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat tidak adapat terukur secara <i>real time</i>
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.

4.1.2 Audit *Bundle* HAI's PPI

a. *Bundle Phlebitis*

Gambar 4.1.2.1 Phlebitis



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan November 2025 sebesar 2,21% dan belum mencapai standart 0%.

Tabel 4.1.2.1 Phlebitis

No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	4
		IRNA 2B	2
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
2	Februari	IRNA 3A	0
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	6
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	1
		ICU	0
3	Maret	IRNA 3A	6
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	6
		IRNA 2B	4
		MATERNITAS	2
		NEONATOLOGI	2
		ICU	0
		IRJA	7
4	April	IRNA 3A	15
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	3
		IRNA 2B	7
		NEONATOLOGI	1
		IRJA	2
5	Mei	IRNA 3A	19
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	26
		NEONATOLOGI	0



		MATERNITAS IRJA	0 0
6.	Juni	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU	9 9 10 17 2 2 2
7.	Juli	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU	11 8 8 15 0 0 0
8.	Agustus	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU	9 6 5 19 0 0 1
9.	September	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU	9 15 13 12 0 0 1
10.	Oktober	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU	16 16 9 20 0 0 0
11.	November	IRNA 3A IRNA 3B IRNA 2A IRNA 2B MATERNITAS NEONATOLOGI ICU	2 7 7 17 1 0 4
TOTAL			441

Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui kejadian plebitis terbanyak di unit IRNA 2B sebesar 17 kejadian.

Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

PROBLEM	Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi



	≤1% dalam 3 bulan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi; b. Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus c. Lama pemasangan infus >72 jam d. Kurangnya pencatatan dan monitoring harian e. Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis 4. Tindakan a. Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus b. Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus c. Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam d. Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis e. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.
STUDY	1. Data kejadian phlebitis pada bulan November sebesar 2,55% dengan rerata 2,62% dan belum mencapai target 0% 2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Audit kepatuhan pelaporan bundle plebitis 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika angka tetap tinggi; b. Evaluasi Kembali penyebab utama c. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan d. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan

Link rekap Plebitis PPI 2025 :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XjGil_YwmlziDYeUHxce3xvO36M89OqWvYhlgKjDDWE/edit?usp=sharing



b. Bundle IDO

Gambar 4.1.2.1 Bundle IDO

Logo Disa Prima Medika		LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2025																				Logo Disa Prima Medika		
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Initial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl/Uam MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi	Da Operasi & Tindakan Operasi	Tim Operasi				Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Pemunjang Abnormal Saat Op		Terapi Saat I.D	Assesmen lain	Produk Penyekab I.D	RTL	Total Kejadian IDO	
											Ast Bg	dr An	Ast An	Instrumen			Onlopp	Saat Op						Saat IDO
Januari																								
Februari																								
1	13/02/2025	NY ZHILA QHRYAH	113009	POLI OBESITAS	27 TH	04/02/2025	DRE NANTICHO	BPJS KLS I	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025
2	26/02/2025	NY N-CHRO UMFI	081324	26	66 TH	11/02/2025	DRE ROBY ZAH	BPJS KLS I	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025
Maret																								
1	05/03/2025	NIL WEIYATI	113070	POLI OBESITAS	34 TH	27/02/2025	DRE ROBY ZAH	BPJS KLS I	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025
2	05/03/2025	FARDA MURDYA	035075	POLI BEDAH	46 TH	24/02/2025	DRE NIFTA	BPJS KLS I	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025
3	07/03/2025	RATNA DWI	000019	POLI BEDAH	42 TH	23/02/2025	DRE ROBY ZAH	BPJS KLS I	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025
4	24/03/2025	LUTYANHOGHI	087805	IBRA SA	38 TH	23/03/2025	DRE NANTICHO	BPJS KLS I	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025
April																								
Mei																								
Juni																								
1	17/06/2025	SCHIFA	121430	POLI OBESITAS	48 TH	02/06/2025	DRE NANTICHO	BPJS KLS I	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025
Juli																								
Agustus																								
1	26/08/2025	MAYA FEDRINA	83218	POLI OBESITAS	28 TH	26/08/2025	DRE NANTICHO	BPJS KLS I	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025
September																								
Oktober																								
November																								
1	17/11/2025	RAKUNO PRALISO	120528	IKO	51 TH	30/10/2025	DRE ROBY ZAH	BPJS KLS I	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025
2	24/11/2025			POLI BEDAH		24/11/2025			24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025
3	26/11/2025			IKO		26/11/2025			26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025
Desember																								

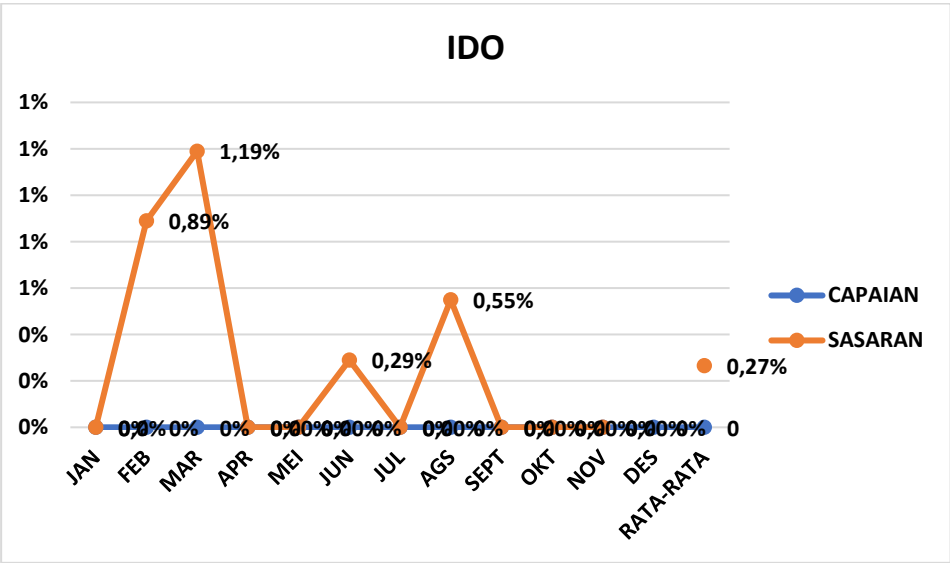


Interpretasi : Berdasarkan gambar 4.1.2.3 dapat diketahui jumlah Bundle IDO di bulan November 0 kasus, namun ada operasi pada pasien yang dilakukan sebanyak 3x karena praduga Ca. Colon

Link Rekap analisa IDO 2025 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-oovztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true

Gambar 4.1.2.2 Bundle IDO



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.2 diketahui bahwa rerata kejadian IDO di bulan November 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 0% pada tahun 2025.

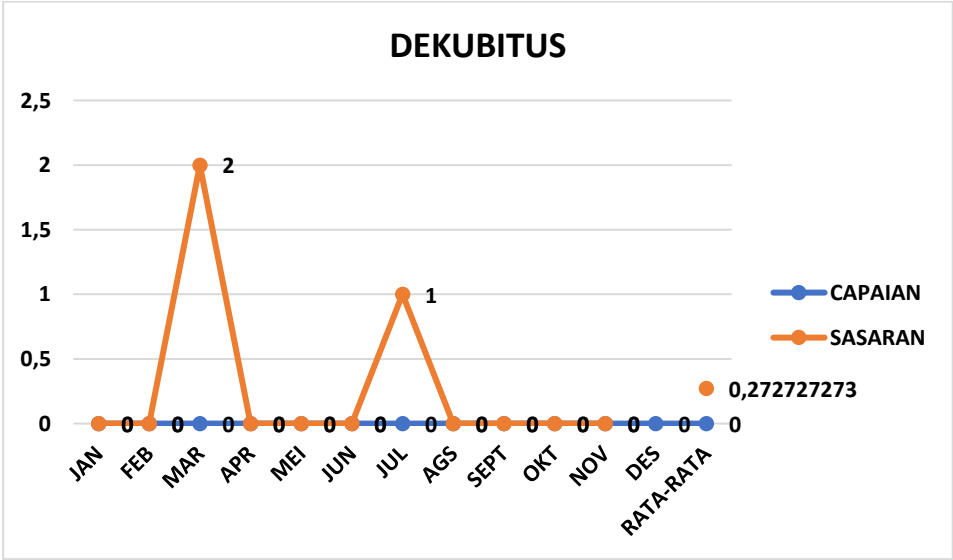
Tabel 4.1.2.3 PDSA Bundle IDO

PROBLEM	Persentase kejadian IDO bulan November 2025 sebesar 0% dengan rerata sebesar 0,27% dan belum mencapai standar 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IRJA, IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian IDO untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian IDO menjadi <0,2% dalam 3 bulan kedepan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian IDO dan dapat menurunkan kejadian IDO di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Kepatuhan asepsis saat operasi belum maksimal b. Sterilisasi alat belum diaudit secara menyeluruh c. Antibiotik profilaksis tidak diberikan tepat waktu d. Monitoring luka pascaoperasi belum optimal 4. Tindakan a. Penegakkan protokol asepsis secara ketat (5 momen kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan penggunaan APD yang sesuai) b. Pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi c. Audit sterilisasi alat operasi d. Monitoring luka operasi dan edukasi pasien

	post-op
DO	Angka kejadian IDO dapat mencapai 0% dengan menerapkan, 1. Terapkan sistem cheklist pre-op untuk memastikan pemberian antibiotik dan sterilisasi 2. Lakukan pelatihan ulang tim bedah dan perawat mengenai protokol pencegahan IDO 3. Audit harian pada ruang operasi dan rawat inap pasca-operasi 4. Edukasi psien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah
STUDY	1. Data kejadian IDO pada bulan November sebesar 0 kejadian dengan rerata kejadian 0,27% dan belum mencapai target 0% 2. Tinjau tren angka IDO setiap minggu 3. Lakukan evaluasi melalui audit kepatuhan prosedur dan insiden harian 4. Identifikasi apakah terjadi penurunan kejadian dan kepatuhan meningkat
ACTION	1. Jika angka IDO menurun : terapkan prosedur sebagai standar dan teruskan monitoring 2. Jika belum berhasil maka, a. Perbaiki SOP sesuai temuan lapangan b. Tambah frekuensi supervise dan audit c. Evaluasi kinerja individu yang tidak patuh dan lakukan pembinaan

c. Dekubitus

Gambar 4.1.2.3 Kejadian Dekubitus



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.3 diketahui bahwa rerata kejadian Dekubitus di bulan November 2025 sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.4 PDSA Bundle Dekubitus

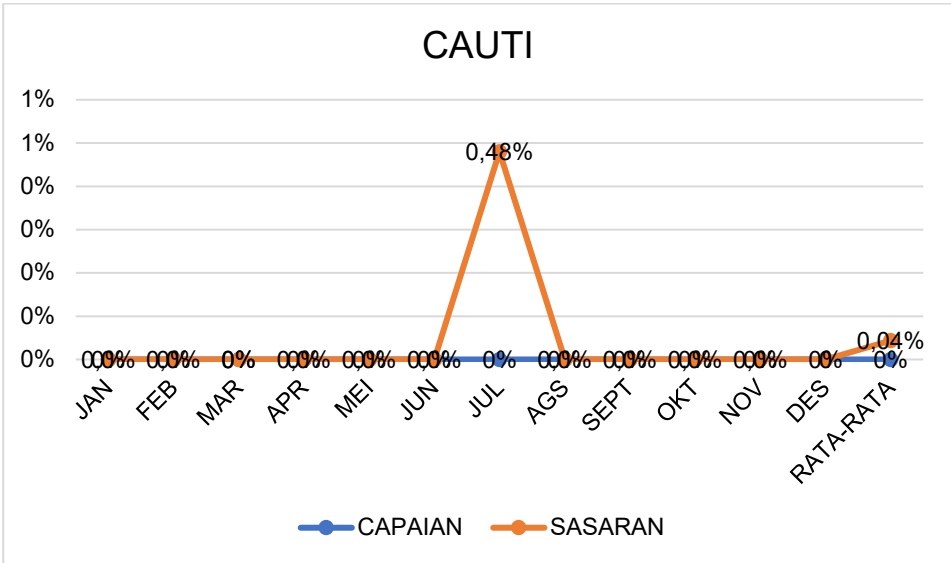
PROBLEM	Kejadian dekubitus pada bulan November sebanyak 0 kejadian
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit rawat inap dan unit khusus (ICU) mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus untuk mengurangi resiko decubitus



	pada pada pasien tirah baring lama melalui peningkatan kepatuhan terhadap pencegahan luka tekan sesuai dengan standart PPI
PLAN	4. Rencana: Menurunkan angka kejadian dekubitus menjadi 0 kejadian dalam 3 bulan . 5. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian dekubitus dan dapat menurunkan kejadian dekubitus di masing-masing unit. 6. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Ketidakpatuhan staff dalam melakukan tindakan keperawatan luka-muka pada pasien tirah baring b. Ketidakpatuhan staff melakukan edukasi terkait penggunaan kasur dekubitus 7. Tindakan a. Melakukan skrining risiko dekubitus menggunakan skala Braden pada saat pasien masuk b. Memberikan pelatihan kepada perawat tentang pencegahan luka tekan c. Menyediakan alat bantu seperti Kasur dekubitus dan posisi miring berkala (2 jam) d. Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini dan perawatan kulit
DO	Angka kejadian dekubitus dapat mencapai 0 kejadian.
STUDY	1. Data kejadian dekubitus pada bulan November sebesar 0 kejadian dengan rerata 0,27 kejadian dan belum mencapai target 0 kejadian 2. Peningkatan kepatuhan dokumentasi perubahan posisi pasien dari 40% menjadi 85% 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Audit kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus di ruangan 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika masih ditemukan kejadian dekubitus maka, a. Evaluasi Kembali penyebab utama b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan c. Melakukan audit bulanan kepatuhan dokumentasi posisi dan perawatan kulit d. Memberikan pelatihan rutin PPI dengan focus pencegahan infeksi dari luka tekan

d. CAUTI

Gambar 4.1.2.4 CAUTI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.4 diketahui bahwa rerata kejadian CAUTI di bulan November 2025 sebesar 0 kejadian

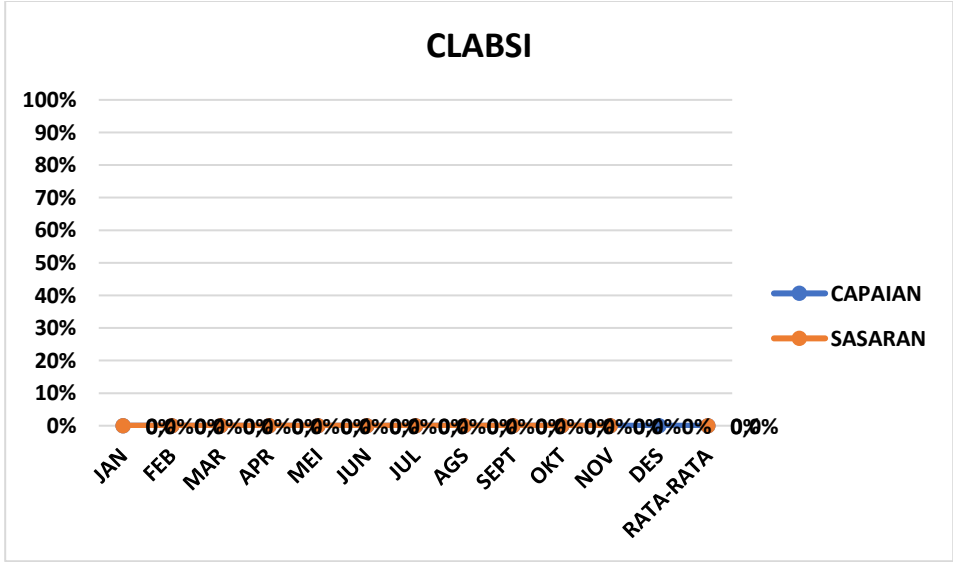
Tabel 4.1.2.4 PDSA CAUTI

PROBLEM	Terjadi lonjakan Angka Sasaran CAUTI hingga 0,48% pada bulan November, menunjukkan ketidakpatuhan atau kegagalan sistem dalam penerapan Bundle CAUTI. Target ideal (0%) belum tercapai.
STEP	Menerapkan audit kepatuhan harian yang ketat pada: - Ketepatan Indikasi Pemasangan Kateter dan - Kebersihan Tangan (<i>Hand Hygiene</i>) saat perawatan kateter.
PLAN	- Tujuan (Goal): Menurunkan Angka Sasaran CAUTI menjadi 0% dalam periode uji coba 1 bulan. - Tindakan (Implementasi): - Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai 5 indikasi yang diperbolehkan untuk pemasangan kateter urin. - Menerapkan "Stiker/Label Harian" pada tas urin pasien yang mencantumkan tanggal pemasangan dan indikasi. - Tim pengawas/PPI melakukan observasi mendadak (<i>spot check</i>) terhadap kepatuhan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan kateter urin. - Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap indikasi pemasangan kateter. - Indikator Proses: Persentase kepatuhan kebersihan tangan perawat sebelum/sesudah perawatan. - Indikator Hasil: Angka Sasaran CAUTI bulanan (diukur dalam 1 bulan berikutnya).
DO	- Melakukan pelatihan kepada perawat dan dokter. - Menerapkan Stiker/Label Harian pada semua pasien yang terpasang kateter di unit uji coba. - Memulai audit harian kepatuhan kebersihan tangan dan audit kebutuhan pelepasan kateter (penilaian setiap hari apakah kateter masih diperlukan). - Tim PPI/Pengawas mengumpulkan data kepatuhan proses

	setiap akhir minggu.
STUDY	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: - Ketepatan Indikasi Pemasangan dan Pelepasan Harian Kateter. - Kepatuhan Kebersihan Tangan saat perawatan. - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran CAUTI pada periode uji coba dengan data lonjakan (Juli 0,48%). * Pertanyaan: Apakah kepatuhan yang meningkat berhasil menurunkan CAUTI menjadi 0%? - Identifikasi Akar Masalah: Jika CAUTI tetap terjadi atau kepatuhan rendah: * Apakah masalahnya adalah lamanya hari pemasangan (indikasi tidak dievaluasi harian)? * Apakah masalahnya adalah teknik pemasangan yang kurang steril? (Jika elemen kebersihan tangan sudah baik).
ACTION	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika CAUTI turun menjadi 0% dan kepatuhan tinggi, standarkan <i>checklist</i> pelepasan harian kateter dan masuk ke dalam SPO. - Perluas penerapan Stiker/Label Harian ke seluruh rumah sakit. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. - Siklus Baru (Jika Gagal): Jika insiden tetap terjadi, gunakan data dari tahap <i>Study</i> untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya. Fokuskan pada elemen bundel yang belum optimal (misalnya, teknik pemasangan kateter yang steril, atau perawatan meatus urinarius).

e. CLABSI

Gambar 4.1.2.5 CLABSI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.5 diketahui bahwa rerata kejadian CLABSI di bulan November 2025 sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.5 PDSA CLABSI

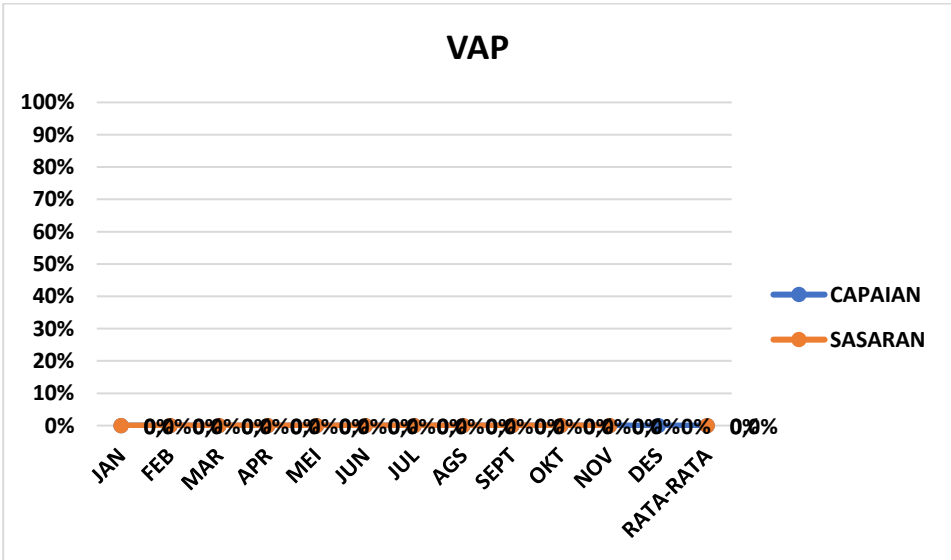
PROBLEM	Angka Sasaran CLABSI saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle CLABSI) perlu diverifikasi dan distandardisasi untuk mencegah lonjakan insiden di masa mendatang.
---------	---



STEP	Audit Kepatuhan pada Perawatan dan Pemeliharaan <i>Central Line</i> : Memfokuskan audit pada Perawatan Balutan (<i>Dressing</i>) dan Penggunaan <i>Checklist</i> Harian Pelepasan Kateter sentral.
PLAN	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden CLABSI 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Bundel Perawatan Kateter Sentral. 2. Tindakan (Implementasi): e. Sosialisasi ulang prosedur dan teknik steril penggantian balutan kateter sentral. f. Menerapkan <i>checklist</i> evaluasi harian untuk menilai perlunya pelepasan kateter sentral (<i>daily necessity review</i>). g. Perawat ruang rawat intensif (ICU) diwajibkan melakukan <i>time-out</i> singkat sebelum penggantian balutan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan penggantian balutan sesuai jadwal dan teknik. b. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran CLABSI bulanan (Target: 0%).
DO	1. Melakukan pelatihan kepada perawat unit terkait (ICU/NICU/unit berisiko tinggi). 2. Menerapkan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter pada semua pasien yang terpasang <i>central line</i>. 3. Tim PPI/Pengawas melakukan audit observasi langsung (minimal 5 kali per minggu) terhadap kepatuhan penggantian balutan.
STUDY	2. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Penggantian balutan steril dan tepat waktu. b. Pengisian <i>checklist</i> pelepasan harian. 3. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran CLABSI tetap 0% selama periode uji coba. * Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 4. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): a. Apakah beban kerja perawat terlalu tinggi? b. Apakah pasokan <i>dressing kit</i> steril tidak tersedia dengan baik?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standardisasikan <i>checklist</i> pelepasan harian dan <i>time-out</i> balutan ke seluruh unit dan masukkan ke dalam sistem manajemen mutu. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif dan <i>reward</i> kepada unit untuk mempertahankan kinerja 0% CLABSI. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem pendukung (misalnya, membuat sistem pengadaan <i>dressing kit</i> menjadi lebih efisien) atau pada elemen bundel CLABSI lain (misalnya, kepatuhan <i>hand hygiene</i> sebelum manipulasi <i>line</i>).

f. VAP

Gambar 4.1.2.6 VAP



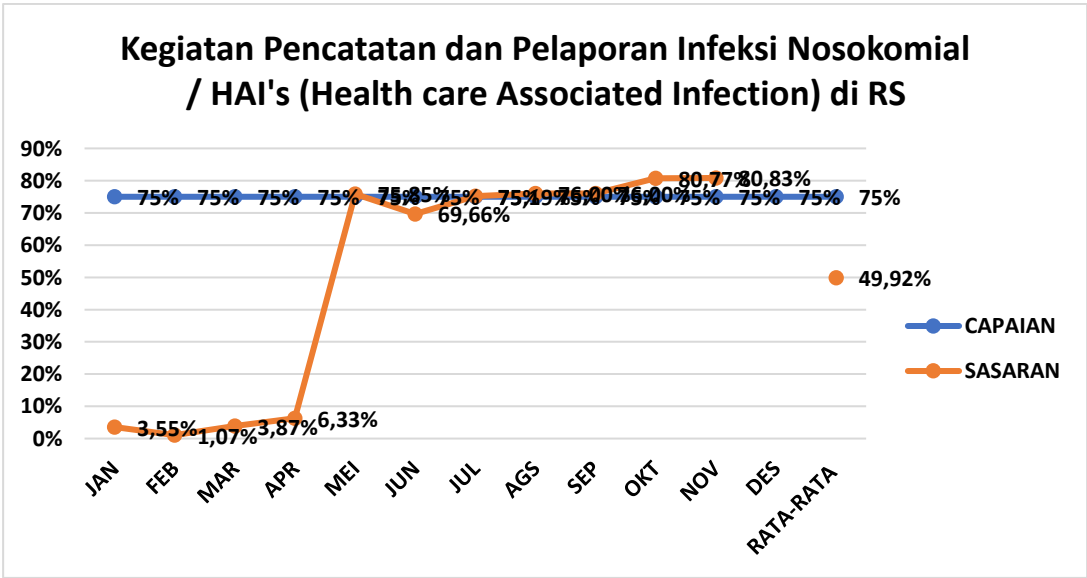
Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.6 diketahui bahwa rerata kejadian VAP di bulan November 2025 sebesar 0 kejadian

Tabel 4.1.2.5 PDSA VAP

PROBLEM	Angka Sasaran VAP saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle VAP) perlu diverifikasi dan ditingkatkan untuk menjamin hasil yang berkelanjutan dan mencegah <i>zero-report</i> yang palsu
STEP	Audit Kepatuhan pada 2 Elemen Inti Bundle VAP: Memfokuskan audit pada 1) Elevasi Kepala Tempat Tidur (30° hingga 45°) dan 2) Penghentian Sedasi Harian (<i>Daily Sedation Interruption</i>).
PLAN	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden VAP 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Elemen Kunci Bundel VAP. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai pentingnya elevasi kepala 30° hingga 45° untuk semua pasien yang terintubasi. b. Menerapkan stiker atau <i>reminder</i> visual di samping tempat tidur pasien untuk mencatat waktu penghentian sedasi harian (<i>sedation vacation</i>). c. Dokter dan Perawat ICU diwajibkan mencatat <i>reason</i> (<i>alasan</i>) jika elevasi kepala kurang dari 30° hingga 45° atau jika <i>sedation vacation</i> tidak dilakukan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan elevasi kepala 30° hingga 45°. b. Indikator Proses: Persentase <i>Daily Sedation Interruption</i> yang berhasil dilakukan. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran VAP bulanan (Target: 0%).
DO	1. Melakukan pelatihan kepada tim ICU (dokter dan perawat). 2. Menerapkan <i>reminder</i> visual dan pencatatan alasan

	pengecualian di setiap <i>bedside</i>. 3. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi mendadak (minimal 5 kali per minggu) untuk mengecek posisi kepala tempat tidur dan pencatatan <i>sedation vacation</i>.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: - Elevasi kepala 30° hingga 45° - Pelaksanaan <i>Daily Sedation Interruption</i>. 2. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran VAP tetap 0% selama periode uji coba. Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): - Apakah ranjang tidak berfungsi dengan baik (<i>technical issue</i>) sehingga sulit mencapai 30° hingga 45° - Apakah dokter atau perawat khawatir akan efek samping <i>sedation vacation</i> (misalnya, ekstubasi diri)?
ACTION	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standardisasikan penggunaan <i>reminder</i> visual dan wajibkan pencatatan alasan pengecualian dalam rekam medis. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif dan penghargaan kepada unit ICU untuk mempertahankan kinerja 0% VAP. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan peralatan (jika ranjang rusak) atau pada elemen bundel VAP lain (misalnya, perawatan kebersihan mulut <i>oral hygiene</i>) jika audit proses menunjukkan ini sebagai area terlemah.

- 4.1.3 Mutu PPI
- a. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's
- Gambar 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.1 diketahui bahwa rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan November 2025 sebesar 80,83% dengan rerata belum mencapai standart 75%.

Tabel 4.1.3.1 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan HAI's

PROBLEM	Persentasi kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien.
PLAN	- Rencana: Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan HAIS mencapai 90% kelengkapan data dalam 3 bulan - Harapan Seluruh staf patuh dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Akar masalah, - Ketidaktahuan peugas tentang format pelaporan HAIs - Kurangnya pemantauan dari tim IPCN/IPCLN - Sistem pencatatan sudah digital namun staf masih tidak patuh - Beban kerja tinggi, menyebabkan pencatatatn tidak menjadi prioritas - Tindakan - Pelatihan ulang tentang HAIs dan pentingnya pelaporan - Distribusi ulang format pelaporan yang mudah dipahami - Monitoring mingguan dari IPCN ke setiap unit
DO	Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's belum mencapai 80% dan akan dilakukan, - Lakukan sosialisasi dan pelatihan awal dalam 1 minggu pertama - Terapkan system pelaporan mingguan berbasis google form (by link : https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo/home) - IPCN melakukan validasi data mingguan selama 3 bulan - Berikan umpan balik kepada unit dengan Tingkat pelaporan rendah
STUDY	- Rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 80,83% dengan rerata 49,92% dan belum mencapai target 75% - Bandingkan Tingkat kelengkapan dan ketepatan laporan HAIs antar unit - Liat tren pelaporan : apakah meningkat dari minggu ke minggu? Adakah perubahan dari bulan sebelumnya? - Identifikasi kesalahan umum dan kesenjangan pemahaman
ACTION	Re-sosialisasi ulang kepada staf terkait langkah pelaporan



	HAI's. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu all pelayanan untuk menghimbau IPCLN/PIC PPI unit untuk patuh dalam melaporkan kejadian HAI's dengan waktu perekapan selama 1 minggu sekali 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's
--	---

b. Kepatuhan Kebersihan Tangan

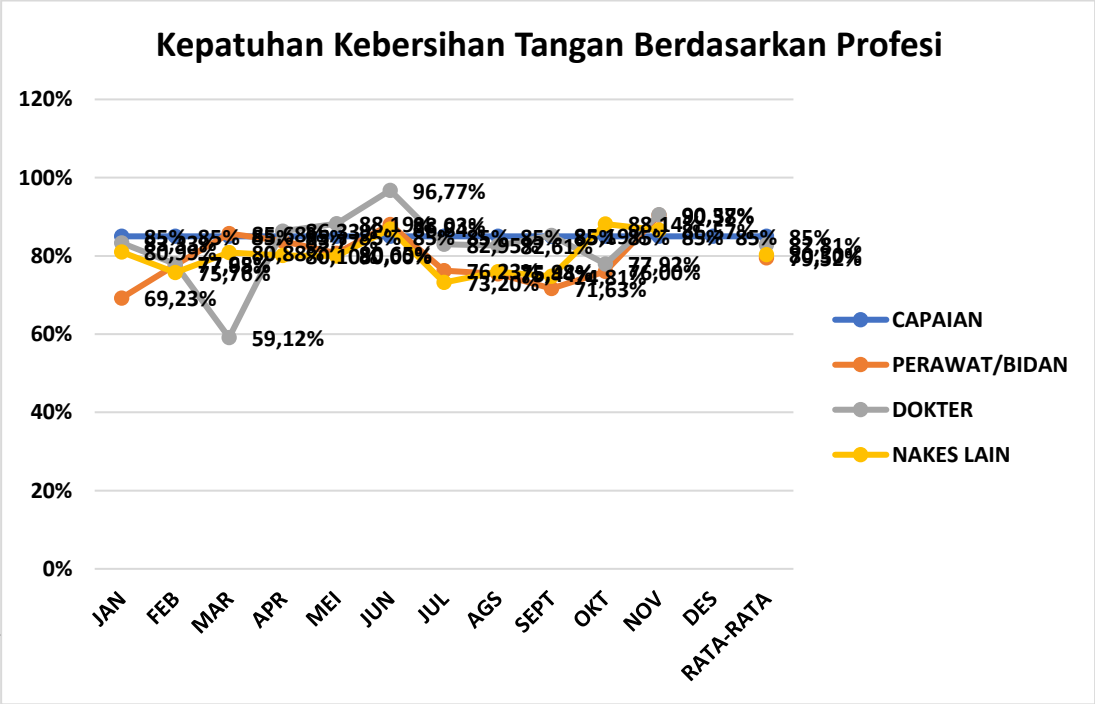
a) Berdasarkan Unit

Tabel 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3A	85%	76,36%	80,77%	88,41%	82,46%	85,11%	95,83%	76,47%	69,23%	75,93%	79,31%	88,64%		81,68%
2	3B	85%	87,50%	44,44%	41,43%	86,96%	85,03%	71,05%	74,29%	69,52%	70,37%	78,05%	100,00%		73,51%
3	2A	85%	100%	50,00%	71,34%	77,91%	69,03%	86,67%	52,50%	69,68%	73,11%	77,78%	83,67%		73,79%
4	2B	85%	100%	100%	78%	77,91%	73,12%	80,85%	58,93%	69,60%	71,21%	66,67%	86,36%		78,42%
5	2D	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
6	MAT	85%	80%	71,79%	68%	86,67%	92,47%	94,00%	85,19%	73,91%	80,00%	84,09%	94,87%		82,83%
7	NEO	85%	72,73%	89,02%	96%	88,79%	93,55%	96,81%	87,10%	91,30%	84,31%	83,04%	94,67%		88,82%
8	ICU	85%	100%	100%	75%	75%	100,00%	65,00%	81,82%	90,91%	83,33%	77,27%	100,00%		86,21%
9	IKO	85%	100%	44,44%	0%	75%	46,15%	0,00%	0,00%	92,00%	71,43%	82,61%	80,00%		53,78%
10	IGD	85%	58,57%	77,78%	84%	82,35%	80,49%	94,59%	87,80%	71,43%	75,00%	76,92%	81,82%		79,14%
11	IRJA	85%	100%	78,23%	83%	84,40%	86,96%	79,07%	71,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		53,02%
12	CS	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
13	As. Center	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
14	Farmasi	85%	100%	72,41%	0%	88,10%	87,36%	100,00%	94,67%	100,00%	76,13%	88,46%	91,80%		81,72%
15	Laboratorium	85%	100%	100%	94%	88,51%	0,00%	0,00%	0,00%	74,19%	70,00%	83,33%	0,00%		55,43%
16	Radiologi	85%	0%	100%	0%	77,78%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	75,00%	70,83%	0,00%		47,60%
17	Gizi dan Dapur	85%	62,50%	78,26%	97%	84,72%	86,65%	88,41%	77,33%	79,49%	74,36%	75,21%	90,41%		81,32%
18	RM / PDF	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
19	CSSD	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
20	LAUNDRY	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%		0,00%

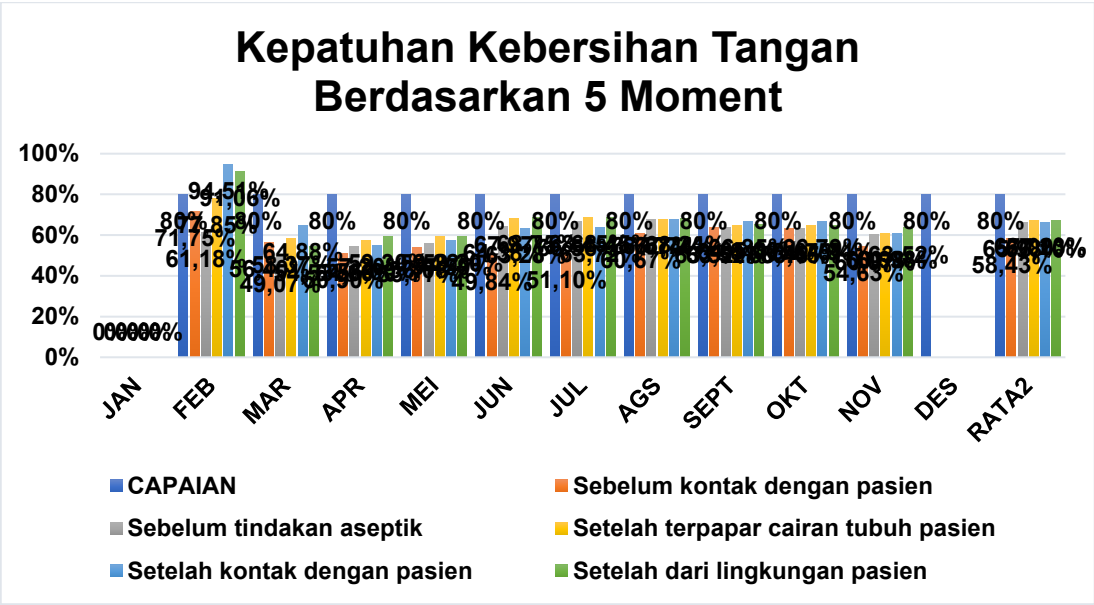
Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.2 diketahui kepatuhan kebersihan tangan pada bulan November 2025 tertinggi berada pada unit Pelayanan (NEO) dengan rerata 88,82% dan unit Penunjang (Farmasi) dengan rerata 81,72%.

b) Berdasarkan Profesi
Gambar 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan November 2025 sebesar tertinggi pada profesi Dokter dengan rerata 90,57%.

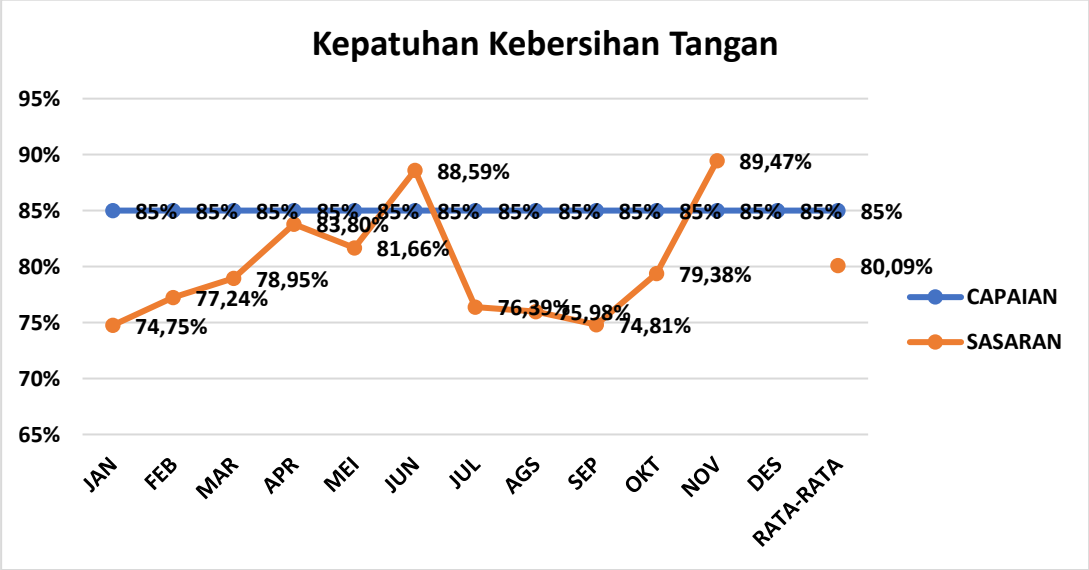
c) Berdasarkan 5 Moment
Gambar 4.1.3.2.1



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 moment di bulan November 2025 sebesar

- Sebelum kontak dengan pasien sebesar 54,63%
- Sebelum tindakan aseptik sebesar 60,07%
- Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 60,98%
- Setelah kontak dengan pasien sebesar 60,98%
- Setelah dari lingkungan pasien sebesar 63,52%

Gambar 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.3 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan November 2025 sebesar 89,47% dengan rerata belum mencapai target 85%.

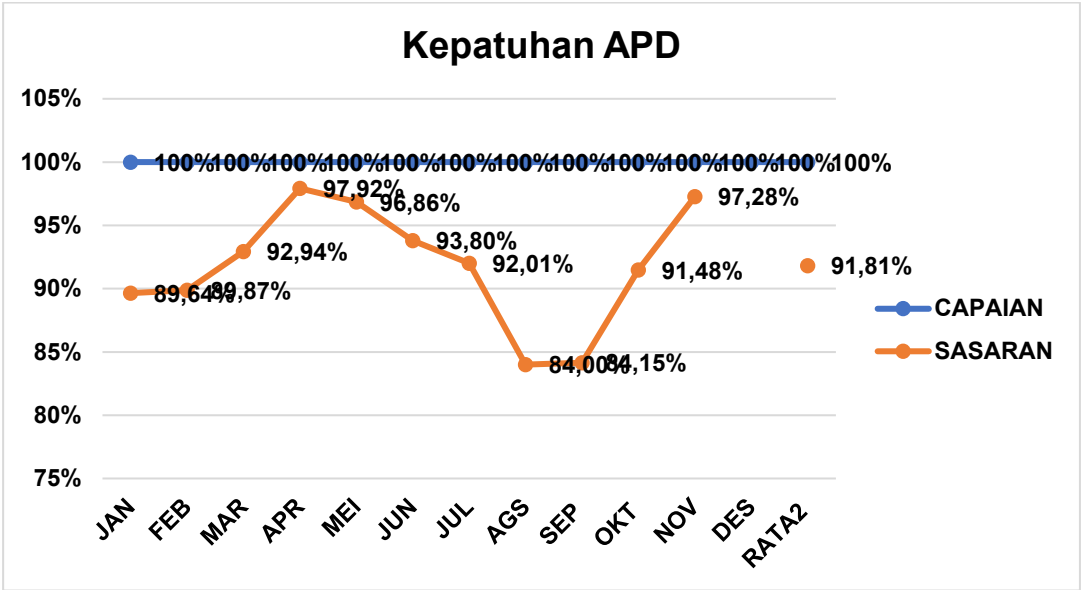
Tabel 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan

PROBLEM	Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan November tahun 2025 sebesar 89,47% dengan rerata 80,09% dan belum mencapai target belum memenuhi target ≥85%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mencapai kepatuhan minimal 90% dalam 3 bulan dan mempertahankan minimal 85% secara berkelanjutan 2. Harapan Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya momen 5 cuci tangan WHO b. Adanya ketidakpatuhan pengisian handrub yang dilakukan oleh CS c. Supervise dan feedback belum dilakukan rutin d. Ketergantungan pada pengingat eksternal tidak menjadi kebiasaan 4. Tindakan a. Audit harian oleh IPCN dengan feedback mingguan b. Manfaatkan poster, QR-code edukasi video, dan pengingat audio di area kritis c. Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan d. Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk seluruh staf pada saat melakukan hand over e. Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan

	sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi.
--	---

f. Kepatuhan APD

Gambar 4.1.3.4 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan November 2025 sebesar 91,48% dengan rerata belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.4 Kepatuhan APD Berdasarkan Unit

INDIKATOR PENILAIAN	BULAN												RATA- RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3A	88,00%	100,00%	93,10 %	95,15%	100,00%	100,00%	69,23%	77,27%	96,30%	95,65%	100,00%		92%
3B	100,00%	90,00%	96,77%	100%	100,00%	100,00%	76,79%	89,74%	61,90%	81,82%	100,00%		91%
2A	33,33%	100,00%	98,04%	100%	100,00%	100,00%	97,14%	73,33%	91,67%	78,57%	96,77%		88%
2B	100,00%	100%	98,77%	100%	100%	100,00%	81%	71,11%	72%	72,22%	90,00%		90%
2D	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%		0%
MAT	88,00%	100%	97,22%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%		99%
NEO	88,89%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%		99%
ICU	100,00%	100%	79,17%	45,45%	0%	100,00%	100%	0,00%	100%	100,00%	100,00%		75%
IKO	100,00%	100%	0%	0%	100%	0,00%	0%	100,00%	100%	0,00%	100,00%		55%
IGD	98,65%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	88%	100,00%	100,00%		99%
IRJA	100,00%	89%	98,98%	100%	100%	100,00%	100%	0,00%	0%	0,00%	0%		63%
CS	27,27%	100%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%		12%
As. Center	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%		0%
Farmasi	100,00%	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	0,00%	100,00%		82%
Laboratorium	83,33%	56%	52,38%	84,62%	0%	0,00%	0%	100,00%	80%	0,00%	0%		41%
Radiologi	60,00%	0%	66,67%	100%	100%	0,00%	0%	0,00%	0%	100,00%	0%		39%
Gizi dan Dapur	83,33%	76%	81,16%	100%	81%	65,22%	100%	66,67%	81%	86,67%	93,51%		83%
RM / PDF	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%		0%
CSSD	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%		9%
LAUNDRY	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%		9,09%
B3	87,72%	93,75%	83,33%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	79,49%	87,18%	0,00%	0%		75,59%
LAIN-LAIN	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%		0,00%

Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD berdasarkan di Unit di bulan November 2025 tertinggi di unit Maternitas dan Neonatologi

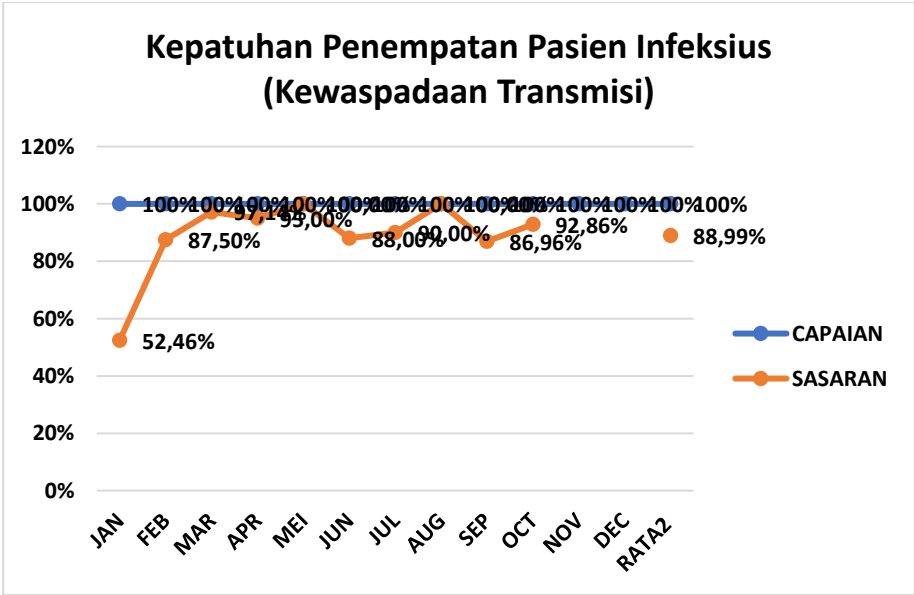
Tabel 4.1.3.5 Kepatuhan APD

PROBLEM	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	- Rencana: Mempertahankan kepatuhan APD di level 100% secara konsisten dalam 6 bulan ke depan - Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Akar masalah potensial - Ketidaknyamanan dalam penggunaan APD (panas, pengap, terlalu besar) - Persepsi bahwa risiko infeksi menurun sehingga kepatuhan bisa longgar - Ketidakteraturan dalam pengawasan langsung di unit - Tindakan - Memberikan pengingat visual di area kerja (poster, stiker, digital signal) - Supervise rutin oleh IPCN/IPCLN - System reward bulanan unit dengan kepatuhan 100% - Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan
DO	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan November tahun 2025 dengan, - Lakukan pemasangan materi edukasi dan pengingat di setiap unit - Lakukan audit dan observasi harian - Berikan umpan balik mingguan dan apresiasi bagi tenaga yang patuh - Lakukan survei kecil mengenai kenyamanan dan persepsi staff tentang APD
STUDY	- Rerata kepatuhan penggunaan APD pada bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 97,28% dengan rerata 91,81% dan belum mencapai target 100% - Pantau tren kepatuhan : apakah tetap stabil di angka 100% - Analisa hasil audit : apabila ditemukan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan - Evaluasi hasil survei kenyamanan dan motivasi tenaga Kesehatan
ACTION	- Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. - Tinjau factor penyebab (misal APD tidak tersedia,

	tidak nyaman dalam penggunaan APD) - Beri feedback pada hasil temuan. - Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. - Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja. - Beri reward pada unit dengan tingkat kepatuhan penggunaan APD 100%
--	--

g. Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Gambar 4.1.3.5 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius di bulan November 2025 sebesar 100% dengan rerata belum mencapai standart 100%.

Tabel 4.1.3.6 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

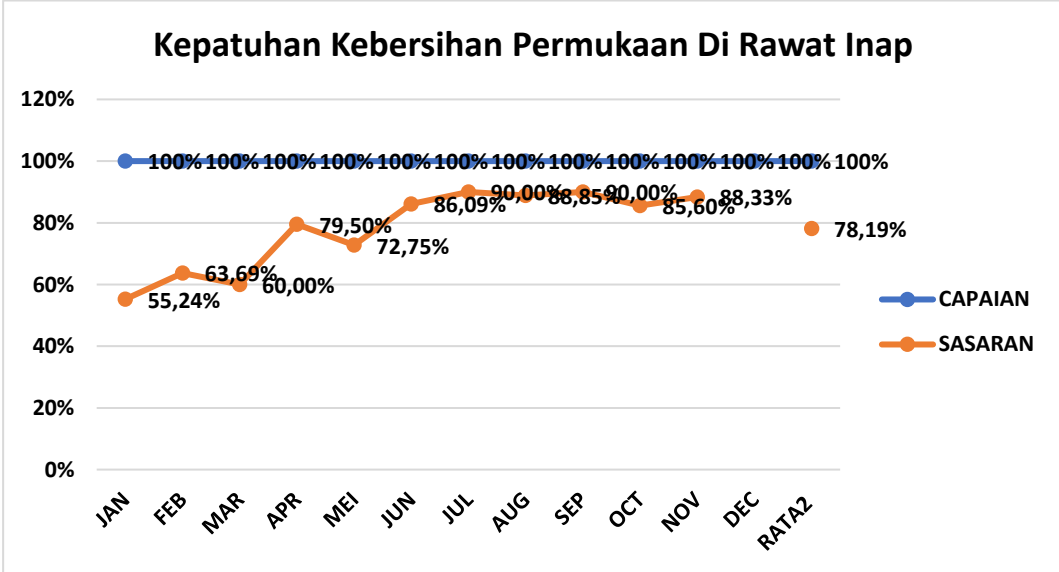
PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	- Rencana: Menajga kepatuhan 100% dalam penempatan pasien infeksius sesuai prinsip kewaspadaan transmisi selama 12 bulan ke depan - Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Akar masalah potensial ;



	a. Ketidaksesuaian pemahaman tenaga jesehatan tentang klasifikasi pasien infeksius b. Sistem triase atau skrining awal tidak optimal c. Ruang isolasi terbatas atau tidak tersedia disaat dibutuhkan 4. Tindakan a. Refresh training tentang identifikasi pasien dengan infeksi menular dan protocol penempatannya b. Standarisasi formuli triase dan SOP pemindahan pasien infeksius c. Evaluasi dan optimasi ketersediaan ruang isolasi d. Audit dan umpan balik harian untuk kasus penempatan pasien baru
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100% dengan melakukan, 1. Lakukan pelatihan ulang kepada perawat IGD, rawat inap dan IPCN 2. Terapkan system checklist pada form masuk pasien terkait status infeksi dan tindak lanjutan 3. Buat system “red flag” di rekam medis pasien dengan infeksi menular 4. Monitoring harian oleh IPCN/IPCLN terhadap semua kasus rawat inap baru
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan rerata 88,99% dan belum mencapai target 100% 2. Review data audit harian atau mingguan : adakah kasus pasien infeksius tida sesuai dengan tempat 3. Tinjau waktu tunggu antara identifikasi infeksius dan pemindahan pasien
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan koordinasi dengan all Karu Rawat inap untuk penempatan pasien menular melalui kontrak dan airborne untuk di pisah dari pasien non infeksius 4. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 5. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 6. Beri feedback pada hasil temuan. 7. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.

h. Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

Gambar 4.1.3.6 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.6 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap di bulan November 2025 sebesar 88,33% dengan rerata 78,19% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.7 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

PROBLEM	Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebersihan permukaan di ruang rawat inap yang dapat meningkatkan resiko infeksi nosokomial
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan kebersihan permukaan menjadi $\geq 90\%$ selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah a. Petugas CS kurang terlatih atau tidak memahami area kritis b. Ketidakteraturan jadwal atau dokumentasi kebersihan c. Tidak adanya verifikasi atau audit lapangan secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Pelatihan ulang petugas CS tentang standart kebersihan permukaan khususnya area sentuh tinggi e. Pembuatan cheklist harian pembersihan permukaan di setiap ruangan (link jobdisk : https://drive.google.com/drive/folders/12xRPis1jwkNrO7



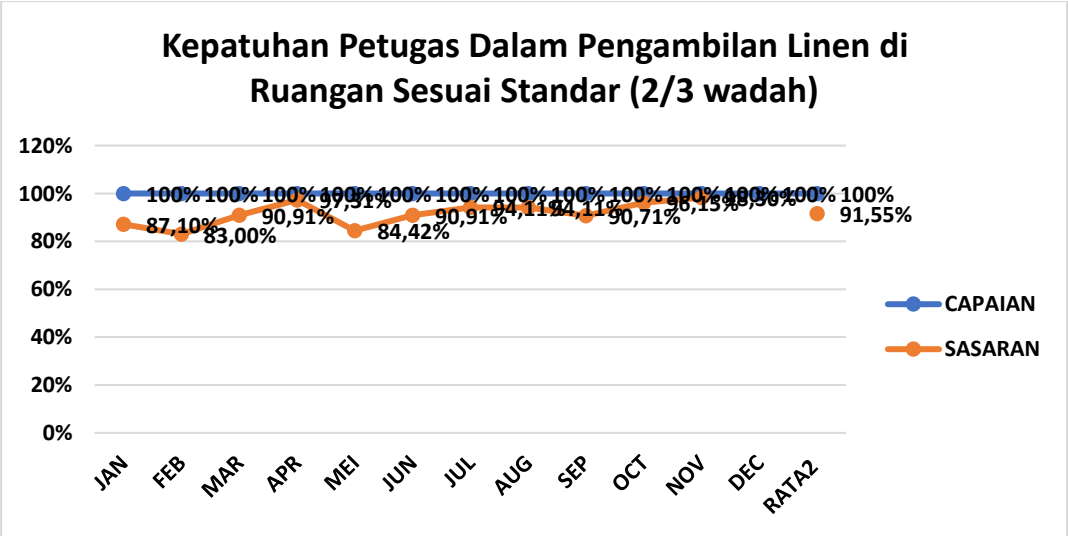
	6kNnKCo73mgiUc51pM?usp=drive_link) 5. Sumber daya - Petugas kebersihan CS yang terlatih - Peralatan pembersih yang memadai - SOP dan panduan visual untuk kebersihan - Peningkatan supervisi lebih sering
DO	Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, - Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Menggunakan checklist untuk memastikan setiap sudut kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi - Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding - Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif - Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan - Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat
STUDY	- Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan November tahun 2025 yaitu sebesar 88,33% dengan rerata 78,19% dan belum mencapai target 100% - Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut, - Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta kamar mandi bau tidak enak - CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor - Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah - Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed - Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai - Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau - Masih ditemukan gorden kotor tidak tercuci - Metrik evaluasi yang digunakan, - Audit kebersihan kamar kosong - Audit kebersihan oleh CS - Audit kebersihan troli tindakan diruang rawat inap - Audit kebersihan di ruang IKO - Evaluasi kebersihan tirai/gorden - Penanganan linen infeksius - Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi
ACTION	- Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit.

4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

- i.

Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangn Sesuai Standart 2/3 Wadah

Gambar 4.1.3.7 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangn Sesuai Standart 2/3 Wadah



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah bulan November 2025 sebesar 98,30% dengan rerata belum mencapai target 100%.

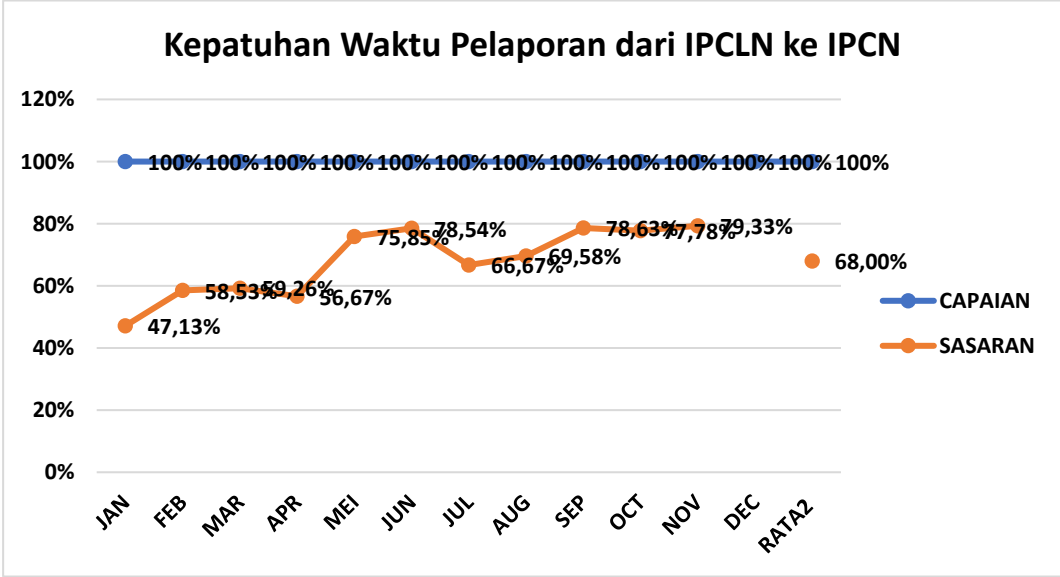
Tabel 4.1.3.8 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangn Sesuai Standart 2/3 Wadah

PROBLEM	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan pengambilan lienn menjadi 100% sesuai standart selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Penyebab yang diidentifikasi; a. Petugas belum paham resiko infeksi silang akibat overfilling b. Kurangnya pengawasan atau evaluasi harian c. Tidak tersedia alterbatif wadah bila kapasitas sudah 2/3 penuh d. Tidak ada system peringatan visual di wadah linen 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart



	2/3 wadah di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. - Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai 2/3 wadah - Sediakan Cadangan wadah linen untuk kondisi penuh agar petugas tidak terpaksa overfill
DO	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya dengan upaya, - Melakukan pelatihan secara singkat kepada petugas kebersihan dan perawat tentang penanganan linen - Tempel stiker batas maksimal 2/3 pada semua wadah linen kotor di setiap ruangan - Terapkan observasi harian oleh petugas IPCN atau kepala ruangan selama satu minggu pertama - Catat Tingkat kepatuhan harian dan lakukan pengingat verbal jika ditemukan pelanggaran
STUDY	- Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. - Evaluasi data observasi dan bandingkan dengan bulan sebelumnya - Lakukan diskusi mingguan dengan petugas terkait tantangan dilapangan - Catat perubahan tren kepatuhan dan identifikasi apakah penandaan visual
ACTION	- Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah - Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. - Berikan system reward / sanksi sederhana berbasis performa petugas - Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor

- j. Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN
- Gambar 4.1.3.8 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.8 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN bulan November 2025 sebesar 79,33% dengan rerata 68% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.9 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN

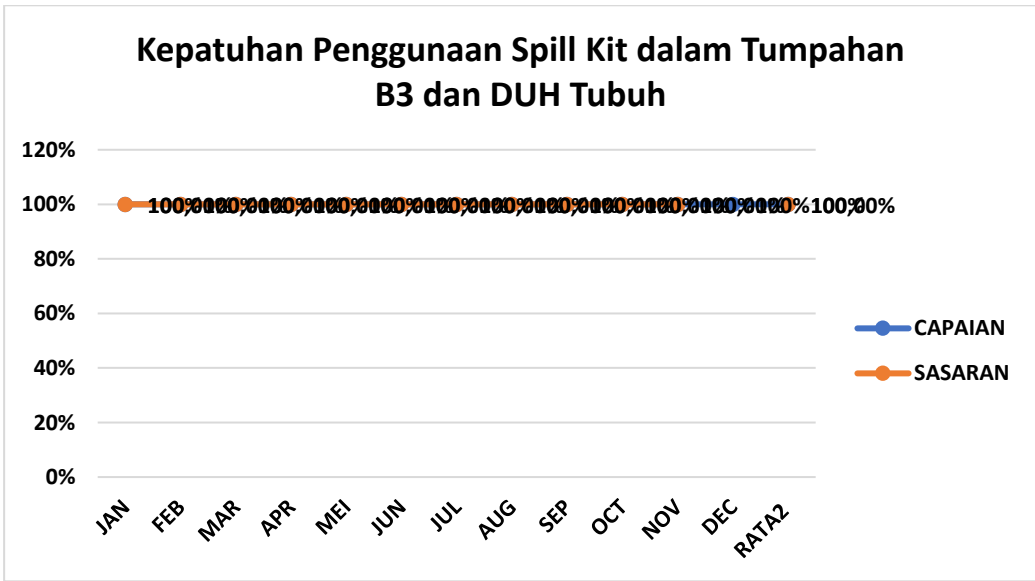
PROBLEM	Pelaporan dari IPCLN (Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Unit) ke IPCN (Petugas PPI Rumah Sakit) tidak dilakukan tepat waktu.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN menjadi $\geq 90\%$ dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Penyebab yang diidentifikasi a. Tidak adanya jadwal pelaporan yang terstandart b. Minimnya kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan tepat waktu c. Beban kerja IPCLN yang tinggi tanpa pengganti saat berhalangan d. Tidak adanya system pemantauan atau pengingat pelaporan 4. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuh IPCLN dan PIC PPI dalam

	melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi. c. Lakukan evaluasi bulanan terhadap kepatuhan pelaporan tiap unit
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans mencapai target 100% dengan upaya, 1. Distribusikan SOP dan jadwal pelaporan kepada seluruh IPCLN 2. Terapkan system pengingat via digital (Wa grub) H-1 dari jadwal pelaporan 3. IPCLN diminta mengisi format laporan harian atau mingguan secara elektronik 4. IPCN mencatat waktu terima laporan dari tiap unit sebagai bahan evaluasi
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan November 2025 sebesar 79,33% dengan rerata 68% dan belum memenuhi standart 100% 2. Bandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi 3. Evaluasi kendala yang muncul selama implementasi 4. Lakukan kuesioner singkat atau FGD dengan IPCLN untuk mendapatkan umpan balik
ACTION	1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMSbAEduydwWaSi-AOWHlxYA8QYuDgE/edit?usp=sharing>

- k. Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam Tumpahan B3 dan DUH Tubuh
- Gambar 4.1.3.9 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.9 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan November 2025 sebesar 100% dengan rerata sudah mencapai target 100%.

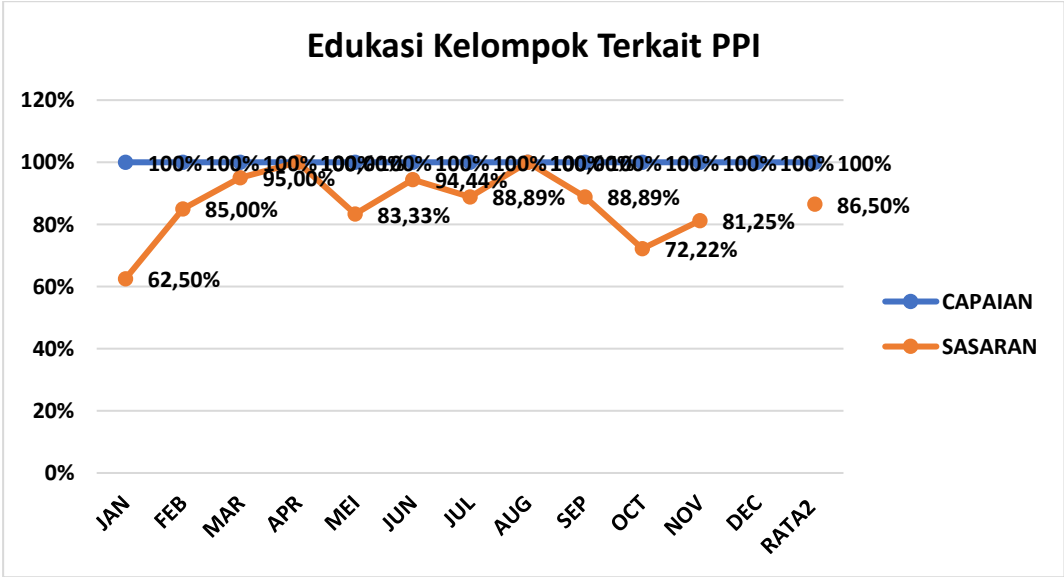
Tabel 4.1.3.10 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

PROBLEM	Petugas tidak menggunakan spill kit secara tepat saat terjadi tumpahan B3 atau darah/urine/cairan tubuh (DUH).
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penggunaan spillkit dalam menangani tumpahan B3 dan DUH tubuh
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan spill kit dalam penanganan tumpahan B3 dan DUH tubuh menjadi $\geq 80\%$ dalam 3 bulan. 2. Penyebab utama a. Spill tidak tersedia dilkoasi yang mudah di akses b. Petugas belum mengetahui prosedur penggunaannya c. Tidak ada pelatihan/praktik secara langsung d. Tidak ada pengawasan atau audit insiden tumpahan 3. Tindakan a. Pastikan keberadaan spill kit diseluruh unit pelayanan beresiko b. Sosialisasi dan pelatihan praktis penggunaan spill kit kepada seluruh petugas c. Tempelkan alur atau poster langkah penggunaan spill kit di area strategis. d. Bentuk tim audit untuk memantau kepatuhan dan tindak lanjut insiden.
DO	1. Distribusikan spill kit ke semua unit yang membutuhkan dan pastikan kelengkapannya 2. Laksanakan pelatihan langsung oleh IPCN/IPCLN (misalnya dengan simulasi tumpahan) 3. Sebarkan media edukasi visual (poster, video singkat). 4. Terapkan form pelaporan jika spill kit digunakan, untuk

	mendokumentasikan insiden.
STUDY	1. Data kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan November tahun 2025 sebesar 100% dengan rerata 100% sehingga sudah mencapai standart 100%. 2. Evaluasi jumlah penggunaan spill kit (dari log pelaporan) dibandingkan jumlah insiden. 3. Lakukan survei singkat pemahaman petugas pasca pelatihan. 4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat insiden terjadi.
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. 4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 5. Analisis kebutuhan spill kit di unit

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0Li6EkPMAypTMA/edit?usp=sharing

- I. Edukasi Kelompok Terkait PPI
- Gambar 4.1.3.10 Edukasi Kelompok terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.10 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI bulan November 2025 sebesar 81,25% dengan rerata 86,05% dan belum mencapai target 100%.



Tabel 4.1.4.11 Edukasi Kelompok terkait PPI

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
Januari					
1	IRNA 2A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
6	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
8	RM/PDF	1	8	Hand hygiene	Staff
9	IKO	1	3	Pencegahan Infeksi pada pasien post op	Pencegahan Infeksi
Februari					
1	IRNA 2A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Pemilahan Sampah	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
5	ICU	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
6	IGD	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	6	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
7	IRJA	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
8	Maternitas	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan infeksi	Pasien/pengunjung
9	Neonatologi	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung



		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
10	RM/PDF	1	8	Cuci tangan	Staff
Maret					
1	IRNA 2A	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	8	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
8	ICU	2	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
9	Radiologi	1	6	Pemilahan sampah	Pasien/pengunjung
10	IRJA	1	2	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
April					
1	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
5	MATERNITAS	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
6	NEONATOLOGI	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pemilahan sampah	Pasien/Pengunjung
7	ICU	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
8	RM	2	8	Cuci tangan	Staff unit
9	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	8	Etika batuk	Pasien/pengunjung
Mei					
1	IRNA 3A	2	5	Etika Batuk	



		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	4	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		2	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
5	IRJA	2	6	Cuci Tangan	Staff
6	Maternitas	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	Perinatologi	1	6	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	6	Pemilahan Sampah	Pasien/Pengunjung
8	ICU	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
9	RM	1	5	Cuci Tangan	Staff
10	IGD	1	7	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	7	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
Juni					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
2	IRNA 3B	3	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Infus Plebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Eefektif	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
7	ICU	3	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
8	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
10	RM	1	8	Cuci Tangan	Staff
Juli					
1	IRNA 3A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Infus Plebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci Tangan	Staff
7	ICU	2	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
8	RM	1	8	Cuci Tangan	Staff



9	Farmasi	1	5	Cuci Tangan	Staff
Agustus					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	4	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/Pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		3	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
5	Maternitas	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/Pengunjung
6	Neonatologi	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
8	ICU	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
September					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	2	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
5	Maternitas	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
8	ICU	4	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
9	RM/PDF	1	6	Cuci Tangan	Staff
Oktober					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	ICU	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung



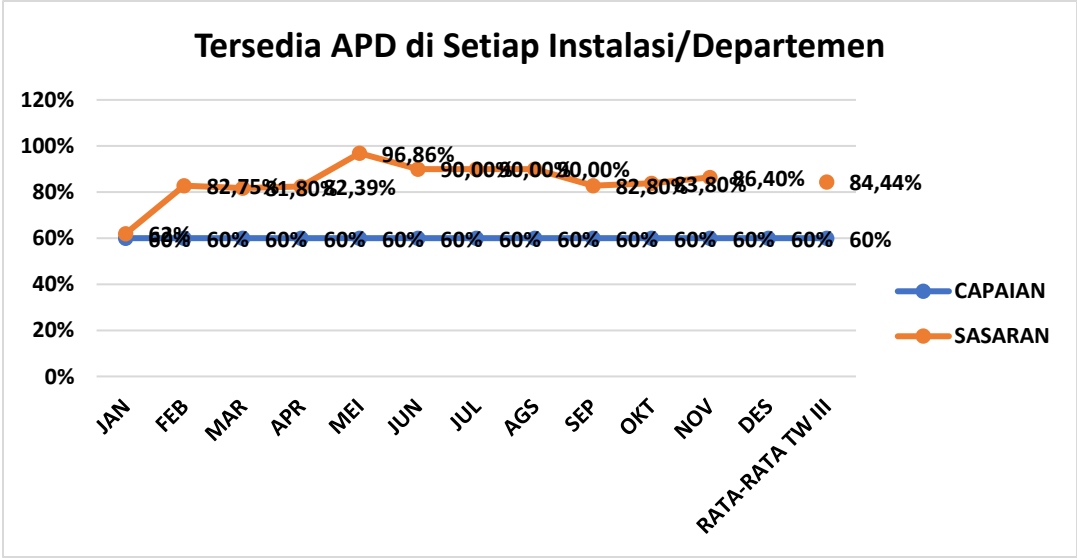
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
8	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Cuci Tangan	Staff
9	RM	1	5	Cuci Tangan	Staff
10	FARMASI	1	5	Cuci Tangan	Staff
November					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
3	IRNA 2B	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
4	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
5	Neonatologi	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
6	ICU	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
7	RM	1	5	Cuci Tangan	Staff
Desember					

Tabel 4.1.4.12 Edukasi Kelompok terkait PPI

PLAN	1. Masalah Edukasi kelompok terkait PPI belum dilaksanakan secara rutin atau terdokumentasi dengan baik. 2. Tujuan Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kelompok PPI $\geq 80\%$ dalam 3 bulan 3. Analisa masalah a. Jadwal edukasi tidak tersusun dengan sistematis. b. Petugas tidak patuh dalam melakukan edukasi c. Dokumentasi edukasi sering terlewatkan. d. Kurangnya koordinasi antar unit dengan IPCN/IPCLN. 4. Strategi a. Susun jadwal edukasi mingguan/bulanan di setiap unit. b. Sediakan materi edukasi PPI yang mudah dipahami pasien/keluarga. c. Buat form standar dokumentasi edukasi (manual/digital). d. Tetapkan PIC edukasi di tiap unit pelayanan.
DO	1. Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi. 2. Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif. 3. Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan. 4. IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal.
STUDY	1. Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan

	terdokumentasi. 2. Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan. 3. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya
ACTION	1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu 2. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu 3. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .

- j. Tersedia APD di setiap Unit
- Gambar 4.1.3.11 Tersedia APD di Setiap Unit



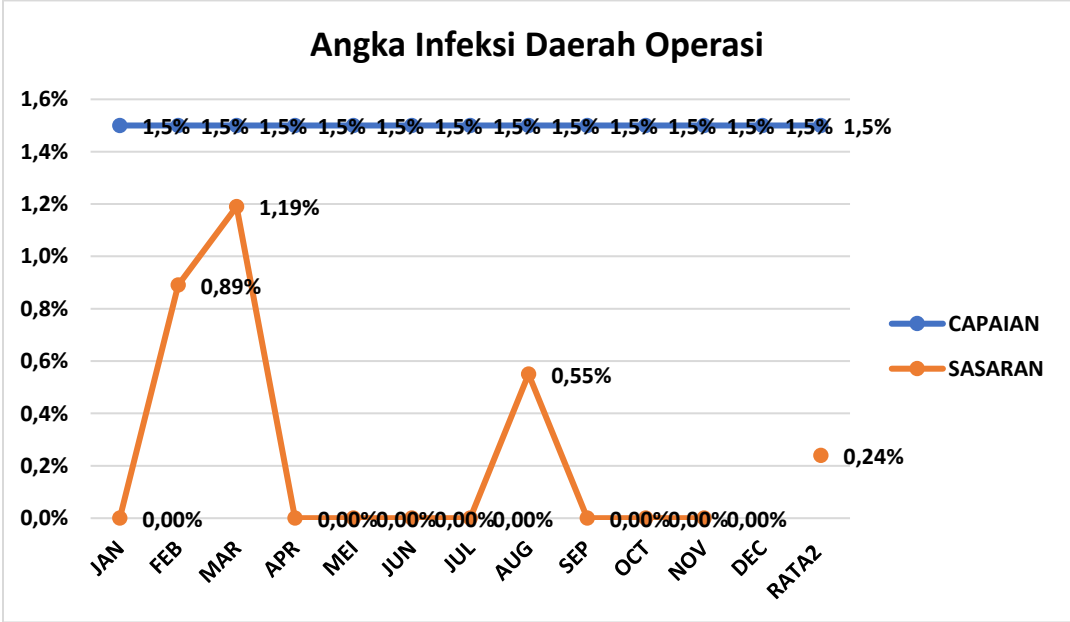
Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.11 diketahui bahwa rerata ketersediaan APD di setiap unit bulan November 2025 sebesar 86,40% dengan rerata 84,44% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.10 Ketersediaan APD di setiap unit

PROBLEM	Ketersediaan APD di unit menjadi salah satu ketidak patuhan penggunaan APD
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya melakukan pengecekan ketersediaan APD di masing-masing unit
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penyediaan APD di masing-masing unit pelayanan 2. Tindakan a. Memastikan ketersediaan APD sesuai dengan kebutuhan unit b. Memastikan semua kebutuhan APD di unit tersedia sesuai dengan penginputan dan pemakaian
DO	Ketersediaan APD di unit sesuai
STUDY	1. Data ketersediaan APD di unit pada bulan November tahun 2025 sebesar 86,40% dengan rerata 84,44% sehingga sudah mencapai standart 60%. 2. Evaluasi ketersediaan APD di unit.

	3. Lakukan survei singkat terkait kepatuhan dan ketersediaan APD apakah sesuai dengan penggunaan atau tidak 4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat adanya ketidaktersediaanya APD di unit
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Monitoring unit terkait ketersediaan APD 3. Supervisi terkait ketersediaan APD 4. Analisis kebutuhan APD di masing-masing unit

k. Angka Infeksi Daerah Operasi
 Gambar 4.1.3.12 Angka Infeksi Daerah Operasi



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.12 diketahui bahwa rerata ketersediaan APD di setiap unit bulan November 2025 sebesar 86,40% dengan rerata 84,44% dan belum mencapai target 100%.

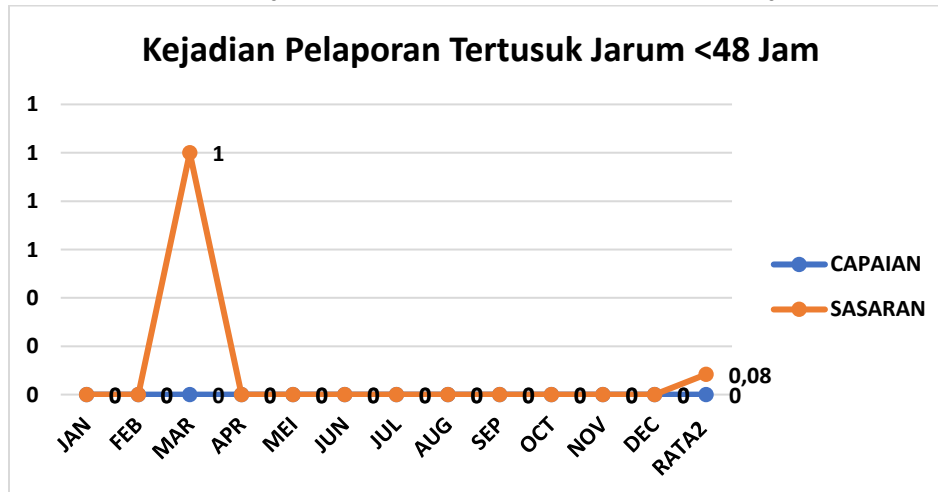
PROBLEM	Terjadi lonjakan Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) Aktual (<i>Angka Sasaran</i>) yang signifikan, mencapai 1,19% (Maret) dan 0,55% (Agustus), menunjukkan ketidakstabilan proses pencegahan infeksi, meskipun target maksimal (Capaian) berada di 1,5%.
STEP	Standardisasi Prosedur Pre- dan Intra-Operasi: Mengimplementasikan audit kepatuhan (checklist) yang ketat pada dua elemen utama Bundel Pencegahan IDO: 1) Waktu Pemberian Antibiotik Profilaksis dan 2) Pengendalian Suhu Tubuh (Normotermia) pasien.
PLAN	1. Rencana: Menurunkan Angka Sasaran IDO hingga di bawah rata-rata (0,24%) dan mencapai 0% selama periode uji coba 1 bulan 2. Tindakan Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai prosedur pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi. Menetapkan <i>checklist</i> wajib untuk memonitor suhu tubuh pasien di kamar operasi dan penggunaan alat penghangat jika diperlukan. 3. Pengukuran



	- Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap pemberian antibiotik tepat waktu. - Indikator Hasil: Angka Sasaran IDO bulanan pada periode uji coba.
DO	- Menerapkan <i>checklist</i> kepatuhan pada semua pasien operasi di unit/kasus yang diuji coba selama 4 minggu. - Mencatat waktu pemberian antibiotik dan suhu tubuh pasien secara akurat pada rekam medis. - Tim PPI melakukan <i>audit harian</i> pada 100% kasus uji coba untuk kepatuhan <i>checklist</i>.
STUDY	- Analisis Kepatuhan: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: - Pemberian antibiotik tepat waktu. - Pencapaian normotermia (suhu tubuh $>36^{\circ}\text{C}$) - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran IDO pada bulan uji coba dengan data dasar - Identifikasi Akar Masalah: Jika IDO tidak turun atau kepatuhan rendah, identifikasi: - Antibiotik: Apakah ketidakpatuhan disebabkan ketersediaan obat, <i>delay</i> di ruang tunggu, atau kurangnya komunikasi? - Normotermia: Apakah alat penghangat tidak berfungsi, atau kurangnya <i>monitoring</i>?
ACTION	- Beri feedback hasil temuan. - Jika IDO turun signifikan dan kepatuhan $>95\%$, jadikan <i>checklist</i> sebagai Standar Prosedur Operasional (SPO) wajib di seluruh kamar operasi. - Beri <i>feedback</i> hasil temuan IDO dan kepatuhan kepada tim bedah. - Jika IDO tidak turun, gunakan data dari tahap <i>Study</i> (misalnya, jika normotermia yang paling rendah) untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya yang berfokus pada elemen bundel IDO yang lain (misalnya, <i>skin preparation</i> / persiapan kulit pra-operasi) atau pada perbaikan sistem pendukung yang gagal.

I. Kejadian Pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam

Gambar 4.1.3.13 Kejadian Pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.13 diketahui bahwa rerata kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam setiap unit bulan November 2025 sebesar 0% dan belum mencapai target 0%.

Gambar 4.1.3.14 Kejadian Tertusuk Jarum <48 jam



BUMAH SARI
PRIMA HUSADA

REKAP LAPORAN PAJANAN PPI
TAHUN 2025



PT. DISA PRIMA MEDIKA

No	Tgl/Lap Laporan	Tgl/Lap Pajanan	Unit	Nama Terpapar	Pejabat	Route Pajanan	Sumber Pajanan	Area Tubuh Terpapar	Kronologi	Jenis APD yang Digunakan	Pertolongan Pertama	Nama Pasien	RM	Diagnosa & Rawat 2x	Tindakan Terpapar	Tindakan Lanjutan
1	2-3-2025	0003/2025	IGD	Robabul Adawiyah	Bacabul Ri	Mata	Darah	Area muka	Saat staff melakukan penyambungan infus ke IV ditemukan bahwa Sd. Robi mendapatkan pecikan cairan infus yang tertapat darah ke area wajah Saat setelah kejadian Sd. Robi melakukan pembasuhan muka menggunakan air mengalir di kamar mandi staff Sd. Robi melaporkan kepada PJ Shift dan dr. Jaga (Dr. Fata) serta ke PJ KIRB dan PJ PPI unit Sd. Robi melakukan pemeriksaan pada tanggal 03/03/2025 ke Pok IPO dengan dr. Gamella Sp. PD	Handsoon	Bilas air mengalir	Ny. Diah Ayutha Susanti	156473	Hipokalemia a. periode paralisis + SOD dengan candidate	Periksa ke Poli IPO dengan dr. Gamella Sp. PD	1. Cek lab = 12 jam pasca pajanan (HbAg + rager, Anti-HCV, HIV 2. Konsultasi dg DPJP yang merawat pasien (dr. Gamella Sp. PD) 3. Pemberian profilaksis sesuai SPO (Obat Taleadro selama 30 hari) 4. Hasil pemeriksaan a. cek Value Hb Imunoglobulin G dengan dosis 2,85 ml (m) tanggal 10/03/2025 b. Value Hepatitis B Gresaca Tgl 10/03/25 (j) Tgl 07/04/25 (j) Tgl 08/02/25 (R)

PROBLEM	Terjadi insiden Kejadian Tertusuk Jarum (<i>Needlestick Injury</i>) (1 kasus di bulan Maret), yang mengindikasikan adanya celah dalam praktik aman dan pembuangan limbah tajam. Target ideal (0) belum tercapai.
STEP	Implementasi "3-Langkah Keamanan Benda Tajam" dan Sosialisasi Pelaporan: 4. Edukasi teknik <i>recapping</i> yang aman (menggunakan teknik satu tangan) atau penghilangan <i>recapping</i> sama sekali. 5. Penempatan <i>safety box</i> yang mudah dijangkau dan segera di dekat titik penggunaan. 6. <i>Refreshment training</i> tentang pentingnya dan alur pelaporan <48 jam.
PLAN	1. Tujuan (Goal): a. Menurunkan insiden Kejadian Tertusuk Jarum menjadi 0 dan mencapai 100% b. Kepatuhan pelaporan tepat waktu (<48 jam) untuk semua kejadian dalam 3 bulan.



	2. Tindakan (Implementasi): a. Audit lokasi penempatan <i>safety box</i> di unit berisiko tinggi (misalnya, IGD, rawat inap, laboratorium) untuk memastikan jaraknya tidak lebih dari 1 meter dari titik penggunaan. b. Membuat poster/leaflet singkat tentang teknik pembuangan yang benar dan alur pelaporan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase ketersediaan <i>safety box</i> yang memenuhi standar penempatan (mudah dijangkau). b. Indikator Hasil: Jumlah Kejadian Tertusuk Jarum (Sasaran) per bulan.
DO	1. Melakukan audit penempatan <i>safety box</i> dan melakukan koreksi segera di unit-unit yang telah ditentukan. 2. Tim PPI memberikan <i>briefing</i> singkat (5-10 menit) tentang teknik pembuangan limbah tajam yang benar dan alur pelaporan <48 jam di setiap <i>shift meeting</i>. 3. Membagikan poster/leaflet sebagai pengingat.
STUDY	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase <i>safety box</i> yang telah dipindahkan/ditempatkan sesuai standar kedekatan (misalnya, mencapai 90% target). 2. Analisis Hasil: Memantau Angka Sasaran insiden tertusuk jarum pada periode uji coba (misalnya, 1 bulan). 3. Identifikasi Akar Masalah: Jika masih terjadi insiden, lakukan <i>root cause analysis</i> (RCA) singkat pada insiden tersebut. Apakah insiden terjadi karena faktor kelalaian (<i>human error</i>), desain alat (<i>safety device</i> tidak tersedia), atau lokasi <i>safety box</i> yang masih jauh?
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Jika insiden 0 dan kepatuhan penempatan <i>safety box</i> tinggi, jadikan penempatan <i>safety box</i> (jarak <1m) sebagai standar operasional dan masukkan ke dalam <i>checklist Patient Safety Rounds</i> 3. Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. 4. Jika insiden tetap terjadi, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada penyediaan dan pelatihan penggunaan jarum berfitur pengaman (<i>safety engineered devices</i>) atau pada audit praktik <i>recaping</i> (teknik satu tangan).

4.2 Kesehatan karyawan
Tabel 4.2. Data Kesehatan Karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	467	206	-	-	-	-	-
4.	April	467	225	-	-	-	Ada penambahan 19 staff yang melakukan MCU Total staff yang belum melaksanakan MCU : 242 staff	
5.	Mei	467	285	-	-	-	Ada penambahan 60 staff yang melakukan MCU Total staff yang belum melaksanakan MCU : 182 staff	
6.	Juni	467	285	-	-	-	-	
		10					10 staff penyaji menjalani uji rectal swab pada tanggal 23/06/2025	Hasil Uji Rectal Swab 1) Rikha : Staphylococcus 2) Rima : Salmonella 3) Veni : Salmonella 4) Bina : Pseudomonas 5) Citra : Eschericia Coli 6) Amel : Salmonella 7) Umi : Salmonela 8) Ratri : Klebsiella 9) Ima : Klebsiella 10) Indy : Escherichia Coli
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember							

Interpretasi : Pada tabel 4.2 terkait data kesehatan karyawan tidak ada kegiatan MCU Staff.

Tabel 4.2.1 Data Kesehatan Karyawan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan staff dalam melakukan kegiatan MCU yang bertujuan untuk skrining utama terhadap rantai infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan
DO	Monitoring kepatuhan staff dalam melakukan MCU karyawan yang dilakukan secara terjadwal
STUDY	Rerata kepatuhan Kesehatan karyawan bulan Maret 0 dikarenakan tidak ada agenda MCU staff dari SDM.
ACTION	1. Koordinasi dengan SDM untuk penjadwalan MCU staff 2. Beri feedback akan adanya temuan hasil dari MCU staff 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan MCU staff secara berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja komite PPI pada tahun 2025 didapatkan masih ditemukan banyaknya penilaian yang tidak mencapai target dan masih ditemukan beberapa masalah seperti,

- a. Kepatuhan petugas dalam melakukan *hand hygien*,
- b. Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD,
- c. Kepatuhan penyuntikan,
- d. Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan,
- e. Kepatuhan penanganan limbah,
- f. Kepatuhan penanganan pembuangan jarum dan benda tajam,
- g. Kepatuhan penanganan tumpahan darah,
- h. Kepatuhan pelayanan makanan,
- i. Kejadian phlebitis dalam 2025,
- j. Ketidakpatuhan petugas dalam melakukan pelaporan dan pengisian di web komite PPI 2025

5.2 Saran

Dari hasil penulisan dan pelaporan tahunan Komite PPI 2025 diharapkan adanya perbaikan yang dapat dilakukan oleh semua unit dalam proses pelaporan dan penugasan dari Komite PPI terkait,

- a. Pengambilan data di unit oleh IPCLN/PIC PPI Unit terkait audit bundle HAI's, pelaporan HAI's, monitoring dan supervisi, sosialis PPI kepada pasien/keluarga/pengunjung pasien,
- b. Evaluasi dalam berjalannya ICRA Program di unit yang berhubungan dengan Bundle HAI's.

BAB VI PENUTUP

Demikian laporan bulan November tahun 2025 Komite PPI disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Pasuruan, 04 November 2025

Mengetahui,
Ketua Komite PPIRS



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

IPCN



Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.



Lampiran :

1. Link Supervisi PPI 2025 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JO8PKQG1PkET_U3IODHmUxZfTRMy1JLkgvpP_PzQRRRA/edit?usp=sharing

2. Link Rekap PPI 2025 :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf750mUyrg4oJueUUI58h-qF3exSXqQd/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true>